REUMATOLOGIA

Espondiloartrites e artropatias

Resumo de tutoria

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

27 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

Objetivos

1- Diferenciar o diagnóstico e tratamento das espondiloartrites;
2- Estudar os sinais clínicos, diagnóstico e tratamento das artropatias;
3- Estudar o diagnóstico diferencial de espondiloartropatias e artropatia;
4- Discutir o diagnóstico e tratamento da artrite séptica;
5- Discutir o impacto da automedicação;
6- Diferenciar o tratamento farmacológico e não farmacológico das artropatias.

Diagnóstico diferencial das artropatias

ARTRITE: processo inflamatório dentro da articulação, manifesto por dor, edema, calor e, eventualmente, rubor. Não é uma doença específica, mas sim um achado comum a diversas condições (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ARTRALGIA: significa, literalmente, dor na articulação. É um termo inespecífico que ganha maior relevância na Reumatologia caso esteja presente por um período de tempo prolongado ou venha associada a outros sinais e sintomas sugestivos de determinada condição (ESTRATÉGIAMED, 2024).

PERIARTRITE: acometimento inflamatório de estruturas que estão em torno da articulação, como bursas e tendões. Pode manifestar-se com sensibilidade local ou dor, em geral, com determinados movimentos ativos. Edema e calor discretos também podem estar presentes (ESTRATÉGIAMED, 2024).

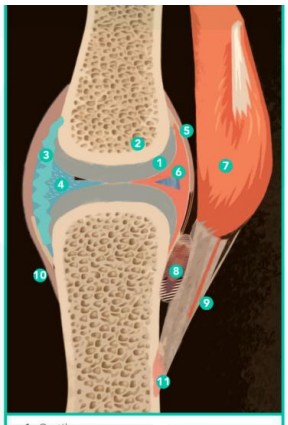


Figura 11: anatomia da articulação do joelho

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS ARTROPATIAS – AVALIAÇÃO DAS QUEIXAS ARTICULARES

1º PASSO: definir se o paciente apresenta artralgia ou artrite.

- Se artralgia: pensar em trauma, osteoartrite, quadro reacional, doenças autoimunes do tecido conjuntivo em fases iniciais;
- Se artrite: pensar em artrite reumatoide, espondiloartrites, artrites microcristalinas, doenças autoimunes do tecido conjuntivo e artrites infecciosas.

2º PASSO: avaliar o número de articulações envolvidas.

- Monoarticular (1 articulação): pensar em artrites microcristalinas (p.ex. gota), artrites infecciosas, osteoartrite, trauma;
- Oligoarticular (2 a 4 articulações): espondiloartrites, febre reumática, artrite gonocócica;
- Poliarticular (mais de 4 articulações): artrite reumatoide, doenças autoimunes do tecido conjuntivo.

3º PASSO: duração das queixas.

- Aguda (duração menor que 6 semanas): trauma, artrites microcristalinas, artrites infecciosas, reumatismo de partes moles (p.ex. bursite, tendinite);
- Crônica (duração maior ou igual a 6 semanas): pensar em artropatias inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, espondiloartrites e doenças autoimunes do tecido conjuntivo.

4º PASSO: topografia das queixas.

- Axial (coluna vertebral, articulações entre coluna e caixa torácica e sacroilíacas): pensar em espondiloartrites, osteoartrite, hiperostose esquelética idiopática difusa (DISH) e, caso envolvimento de coluna cervical, artrite reumatoide;
- Periférica (as demais articulações do esqueleto): artrite reumatoide, osteoartrite, espondiloartrites de predomínio periférico (p.ex. artrite psoriásica, artrite reativa e artrite enteropática), artrites microcristalinas, artrites infecciosas.

5º PASSO: simetria das queixas.

- Simétrica: pensar em artrite reumatoide, doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (p.ex. lúpus eritematoso sistêmico);
- Assimétrica: pensar em espondiloartrites, osteoartrite, artrites microcristalinas e artrites infecciosas.

6º PASSO: padrão temporal de acometimento articular.

- Padrão migratório: as queixas articulares previamente presentes em determinadas articulações melhoram e os mesmos sinais e sintomas surgem em outras. Nesse caso, devemos pensar, especialmente, em febre reumática e artrite gonocócica em sua fase inicial (poliartralgia);
- Padrão aditivo: as queixas articulares vão somando-se ao longo do tempo e, diferentemente do padrão migratório, as articulações previamente acometidas juntam-se às envolvidas mais recentemente. A artrite reumatoide é o padrão aditivo clássico das poliartrites, mas lúpus e outras doenças autoimunes do tecido conjuntivo também podem cursar com esse padrão.

7º PASSO: presença e duração da rigidez matinal.

- Ausência ou duração menor que 30 minutos: pensar em osteoartrite; e
- Duração maior que 30 minutos, especialmente se maior que 60 minutos: pensar em artropatias inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide.

8º PASSO: ritmo da dor.

- Inflamatório: piora com repouso, melhora com o movimento e, em geral, associada à rigidez matinal. Pensar em artropatias inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide e doenças sistêmicas do tecido conjuntivo (p. ex. lúpus eritematoso sistêmico);
- Mecânico: melhora com o repouso e piora com o movimento, tendendo a surgir ou piorar no início do movimento (protocinética) ou após longos períodos de permanência da articulação envolvida, em uma mesma posição. Em geral, sem rigidez ou, se presente, menor que 30 minutos. Pensar em osteoartrite.

Júlia Morbeck – @med.morbeck

9º PASSO: presença de sintomas constitucionais.

- Presença de sintomas, como febre, anorexia, perda de peso e astenia: pensar em doenças inflamatórias sistêmicas, como lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide;
- Presença de febre e queda do estado geral agudos: pensar em artrites infecciosas, especialmente séptica; e
- Ausência de sintomas constitucionais: pensar em osteoartrite, gota, trauma.

ATENÇÃO: A faixa etária e o gênero também são importantes (ESTRATÉGIAMED, 2024).

DOENÇA	EPIDEMIOLOGIA CLÁSSICA
Artrite reumatoide	Mulheres adultas (mais de meia-idade)
Lúpus eritematoso sistêmico	Mulheres adultas em idade reprodutiva
Espondiloartrites	Homens jovens
Osteoartrite	Mais mulheres após a menopausa
Gota	Homens a partir dos 30 anos (mais de meia-idade)
Febre reumática	Crianças e adolescentes
Fibromialgia	Mulheres adultas
Artrite séptica	Todas as faixas etárias e ambos os sexos
Artrite gonocócica	Adultos jovens
Polimialgia reumática	Mulheres após os 50 anos

Tabela 5: perfil epidemiológico de doenças reumatológicas

Por fim, a presença de determinadas manifestações extra-articulares pode sugerir fortemente determinados diagnósticos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

DOENÇA	MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES TÍPICAS
Lúpus eritematoso sistêmico	*Rash* malar, fotossensibilidade, alopecia, úlceras orais, serosites, glomerulonefrite
Artrite reumatoide	Nódulo subcutâneo, doença pulmonar, serosites, acometimento ocular
Espondiloartrites	Uveíte, conjuntivite, psoríase, ceratoderma blenorrágico, balanite circinada
Vasculites	Púrpura, neuropatia periférica, acometimento renal
Esclerose sistêmica	Espessamento cutâneo, fenômeno de Raynaud, disfagia, pneumopatia
Dermatomiosite	Fraqueza muscular proximal, heliótropo, pápulas de Gottron
Febre reumática	Febre, cardite, coreia, histórico de infecção de orofaringe
Síndrome de Sjögren	Sintomas secos (p.ex. xerostomia e xeroftalmia)

AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM MONOARTRITE

Os principais diagnósticos diferenciais frente à monoartrite aguda são artrite séptica, artrites microcristalinas e trauma (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Ainda que achados clínicos e laboratoriais possam ser sugestivos de determinada condição, a única forma assertiva de realizar o diagnóstico diferencial frente à monoartrite aguda é com a punção articular ou artrocentese e análise do líquido sinovial (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tipo de líquido	Aparência	Contagem celular/ mm³	Porcentagem (%) de polimorfonucleares	Exemplos
Normal	Claro, viscoso	0 a 200	< 10	
Não inflamatório	Claro a discretamente turvo com redução da viscosidade	200 a 2.000	< 20	Trauma Osteoartrite
Inflamatório	Discretamente turvo com redução da viscosidade	2.000 a 50.000	20-75	AR Espondiloartrites Artrites microcristalinas
Infeccioso (séptico, pioartrite)	Turvo, com redução da viscosidade e purulento em alguns casos	50.000 a 100.000	> 75	Artrite séptica Artrite gonocócica *
* Também está associada a líquido sinovial com características inflamatórias.				

Tabela 5: análise do líquido sinovial.

AVALIAÇÃO DO PACIENTE COM POLIARTRITE

As principais causas de poliartrite aguda são infecções virais. Em geral, os pacientes apresentam-se com sintomas constitucionais e podem apresentar outras manifestações clínicas, como rash cutâneo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

VIRAIS	BACTERIANAS
Hepatites B e C	Gonocócica
HIV	Doença de Lyme
Arboviroses (especialmente chikungunya)	Endocardite
Parvovírus	Febre reumática aguda*

Tabela 6: diagnósticos diferenciais de poliartrite aguda.

ATENÇÃO: Doenças de caráter inflamatório crônico, como artrite reumatoide e LES, podem apresentar-se com poliartrite aguda em suas fases iniciais, mas, sem dúvida, o diagnóstico a ser descartado nesse momento é o infeccioso (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 7: principais exames para investigação de poliartrite crônica	
Exames gerais: hemograma, transaminases, função renal	PCR e VHS
Fator reumatoide	Anti-CCP
FAN	HLA-B27 (se suspeita de espondiloartrites de predomínio periférico)
Eletroforese de proteínas	Sorologias para hepatites B, C e HIV
TSH/T4 livre	Radiografias convencionais das articulações acometidas

Tabela 7: principais exames para investigação da poliartrite crônica.

Espondiloartrites

→ Grupo específico de doenças reumáticas de caráter inflamatório sistêmico que envolvem o esqueleto axial e/ou periférico e que, em comum, possuem mecanismos genéticos e fisiopatológicos, além de manifestações-satélite típicas (entesite e dactilite) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

CLASSIFICAÇÃO

OBS.: Na década de 1970, Moll e Wright criaram a denominação espondiloartropatias soronegativas para definir um grupo de doenças que compartilhavam o fato de não estarem relacionadas ao fator reumatoide e apresentarem manifestações articulares diferentes das vistas na artrite reumatoide. Passaram-se alguns anos até que os especialistas notassem a necessidade de adequar o termo utilizado até então tendo em vista o caráter inflamatório presente em todas essas condições. Foi assim que deixamos de usar a denominação "espondiloartropatia" e adotamos "espondiloartrite", que denota inflamação nas articulações das vértebras (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Com relação especificamente aos achados de radiografia em sacroilíacas, podemos classificá-las em: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Espondiloartrite axial não-radiográfica: sacroiliíte visualizada apenas na ressonância magnética;
- Espondiloartrite axial radiográfica (mais conhecida como espondilite anquilosante): sacroiliíte visível na radiografia convencional.

↠ Na prática, viu-se que a divisão rígida entre axial e periférico não atendia à maior parte dos casos e, por isso, optou-se pela subdivisão de acordo com o predomínio dos sintomas em: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Júlia Morbeck – @med.morbeck

- Predominantemente axial;
- Predominantemente periférico.



↠ Por fim, existem casos com manifestações periféricas típicas, mas que não "fecham" critérios para nenhuma doença em específico e, por isso, recebem a denominação de "espondiloartrites indiferenciadas" (ESTRATÉGIAMED, 2024).

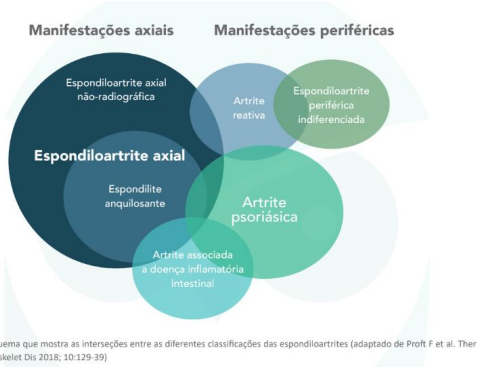


Figura 2: Esquema que mostra as interseções entre as diferentes classificações das espondiloartrites (adaptado de Proft F et al. Ther Adv Musculoskelet Dis 2018; 10:129-39)

Espondilite anquilosante (EA)

↠ A espondilite anquilosante é o protótipo das espondiloartrites (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A EA é uma doença inflamatória crônica e progressiva do esqueleto axial com sacroileíte (em geral bilateral) como principal característica. As articulações periféricas e as estruturas extra-articulares também podem ser afetadas (JAMESON et al., 2021).

↠ Manifesta-se mais em homens na segunda ou terceira décadas de vida; forte associação com o antígeno de histocompatibilidade HLA-B27 (JAMESON et al., 2021).

Perfil clássico: homem, branco, menor que 40 anos.

OBS.: A genética é responsável por 90% do risco de um indivíduo desenvolver espondilite anquilosante e, sem dúvida alguma, o HLA-B27 é o fator mais importante implicado nesse processo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

O complexo principal de histocompatibilidade (MHC) é uma grande família de genes localizada no cromossomo 6 e responsável por codificar as proteínas presentes nas membranas de células especializadas na apresentação de antígenos. Ele está presente em todos os mamíferos e, em humanos, recebe uma denominação específica: antígeno leucocitário humano (HLA) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

A apresentação de antígenos é feita, basicamente, pelas classes I e II e diversas doenças reumáticas estão diretamente associadas a alterações (polimorfismos) no HLA dessas classes, como a espondilite anquilosante e a artrite reumatoide (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Dentre os indivíduos que possuem esse alelo, apenas 2% a 6% desenvolvem espondilite anquilosante ao longo da vida. No entanto, se tiverem algum familiar de primeiro grau com espondilite, essa taxa sobe para 15% a 20%. Por isso, você notará que os critérios classificatórios das espondiloartrites sempre envolverão histórico familiar (ESTRATÉGIAMED, 2024).

FISIOPATOLOGIA

↠ Está relacionada com ativação imune e produção de citocinas inflamatórias. As principais envolvem peptídeos presentes em alguns patógenos que, por serem estruturalmente semelhantes a proteínas endógenas (self), ao serem apresentados aos linfócitos T pelo HLA-B27 desencadeiam uma resposta imune aberrante. Além disso, acredita-se que alterações estruturais no alelo B27 também contribuam para sua fisiopatologia (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: A estrutura-alvo do processo inflamatório é a ênteses (local em que tendões, ligamentos, cápsula articular e fáscia se inserem no osso) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

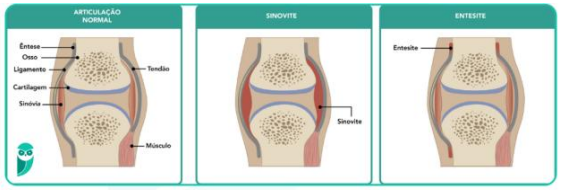


Figura 3: diferença entre uma articulação normal, sinovite e entesite.

Alguns agentes infecciosos têm um mimetismo molecular com proteínas do self e, por isso, quando nosso organismo se prepara para combater esses patógenos, acaba desencadeando fenômenos autoimunes. Mas, no contexto das espondiloartrites, incluindo a espondilite anquilosante, outros dois fatores ganharam destaque nos últimos anos: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Estresse mecânico;
- Alterações na microbiota intestinal (disbiose).

↠ Uma vez que estímulos imunológicos e/ou mecânicos desencadeiem a entesite, ocorre um estímulo à produção da prostaglandina E2 (PGE2) e da interleucina 23 (IL-23), seguido por vasodilatação e ativação de outras células do sistema imune que liberarão outras citocinas,

como o fator de necrose tumoral (TNF) e a interleucina 17 (IL-17), gerando um "círculo vicioso" que culmina com lesão de estruturas articulares e extra-articulares (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Além da inflamação, a ação dessas citocinas também leva a alterações locais no metabolismo ósseo, permitindo a neoformação óssea e dando origem aos sindesmófitos na coluna, responsáveis por uma das alterações radiográficas mais típicas da espondilite anquilosante: a "coluna em bambu" (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 4: fisiopatologia das espondiloartrites, incluindo a espondilite anquilosante.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Manifestações axiais

↠ O sintoma cardinal e mais frequente da espondilite anquilosante é, sem dúvida, a dor lombar decorrente do processo inflamatório nas sacroilíacas e/ou coluna vertebral (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Dor e rigidez nas costas: não aliviadas pela posição deitada, manifestam-se mais frequentemente à noite, obrigando o paciente a deixar a cama, pioram pela manhã, melhoram com a atividade, têm início insidioso e duração superior a 3 meses (recebem com frequência a designação de lombalgia "inflamatória") (JAMESON et al., 2021).
- A dor pode ser localizada na região lombar baixa ou irradiar para a face posterior dos membros inferiores. Devido ao acometimento específico das sacroilíacas, alguns pacientes relatam dor profunda na região superior das nádegas, que de início pode assumir caráter alternante até que se torne contínua (ESTRATÉGIAMED, 2024).
- Em estágios mais avançados a coluna cervical também pode ser envolvida, resultando em dor e rigidez articular (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 3: critérios para dor lombar inflamatória segundo o ASAS (2009)
PARA APLICAÇÃO EM PACIENTES COM LOMBALGIA CRÔNICA (HÁ MAIS DE 3 MESES)
Idade de início < 40 anos
Início insidioso
Melhora com exercício
Sem melhora com repouso
Dor à noite (com melhora ao levantar-se)

	INFLAMATÓRIA	MECÂNICA
Idade de início	Abaixo dos 40 anos	Qualquer idade (geralmente, pacientes de idade mais avançada)
Início	Insidioso	Agudo (geralmente com relato de trauma associado)
Duração	Mais de 3 meses	Menos de 4 semanas
Rigidez matinal	Mais que 30 minutos	Ausente ou menos que 30 minutos
Dor noturna	Presente	Ausente
Efeito do exercício	Melhora	Piora
Efeito do repouso	Piora	Melhora
Dor em nádegas	Presente	Ausente
Mobilidade da coluna	Redução da flexão lombar e, tardiamente, em todos os eixos de movimento	Redução, em geral, apenas da flexão
Déficits neurológicos	Raro	Mais frequente (por exemplo, na radiculopatia)
Exemplo de patologias	Espondiloartrites	Hérnia discal Estenose de canal lombar

Manifestações periféricas

- Artrite periférica: ombro e quadril podem ser envolvidos, mas há um padrão de acometimento articular que é muito sugestivo de espondiloartrites, incluindo a espondilite com acometimento periférico (ESTRATÉGIAMED, 2024).

PADRÃO DE ACOMETIMENTO PERIFÉRICO NAS ESPONDILOARTRITES

- Oligoarticular
- Assimétrico
- Predominantemente de membros inferiores

- Entesite: a ênteses mais classicamente acometida em pacientes com espondiloartrites é a do tendão de Aquiles localizada na região do calcâneo. A principal queixa dos pacientes é dor; edema pode estar presente em alguns casos (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 6: note o aumento de volume na topografia do calcâneo denotando processo inflamatório na inserção do tendão de Aquiles (entesite)

- Dactilite ou "dedo em salsicha": decorre de tenossinovite dos tendões flexores e é caracterizada por edema difuso em toda a extensão de dedos das mãos e dos pés (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Manifestações extra-articulares

↠ Todas as espondiloartrites são consideradas doenças sistêmicas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

A espondilite anquilosante não costuma cursar com quadro constitucional marcante, mas uma queixa em específico parece bem

associada à atividade da doença: fadiga. Outras, como febre, redução do apetite e perda de peso, são incomuns (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Oculares: a manifestação extra-articular mais comum da espondilite anquilosante é a uveíte anterior aguda (UAA). O acometimento do compartimento anterior da úvea pode envolver apenas a íris (irite) ou também o corpo ciliar (iridociclite) e é encontrado em cerca de 30% a 40% dos pacientes com espondilite. Em geral, os pacientes apresentam queixa unilateral abrupta de dor, hiperemia e borramento visual. Os sintomas costumam melhorar em poucos dias ou semanas e, na maioria dos casos, evoluem sem complicações (ESTRATÉGIAMED, 2024).



OBS.: A UAA é fortemente associada à presença do alelo HLA-B27. Dentre os pacientes com espondilite anquilosante que apresentam essa manifestação, 90% apresentam esse marcador genético e, dentre aqueles que chegam primeiro ao oftalmologista com queixas compatíveis com UAA, 50% a 80% possuem alguma espondiloartrite subjacente quando investigados (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 4: manifestações extra-articulares da espondilite anquilosante	
CARDÍACAS	**Insuficiência aórtica,** aortite, distúrbios de condução.
PULMONARES	**Fibrose apical** (figura 8)
RENAIS	**Nefropatia por IgA**, amiloidose AA (secundária).

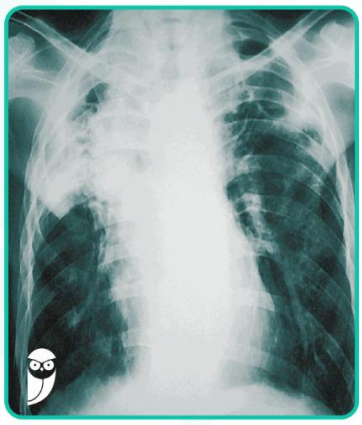


Figura 8: radiografia de tórax de paciente com espondilite anquilosante mostrando fibrose no ápice do pulmão direito

EXAMES LABORATORIAIS

↠ Nenhum exame, isoladamente, confirma o diagnóstico de espondilite anquilosante, incluindo o HLA-B27 (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Por tratar-se de uma doença sistêmica, pacientes em atividade geralmente apresentam elevação de provas de atividade inflamatória, como proteína C-reativa (PCR) e velocidade de hemossedimentação (VHS) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

EXAMES DE IMAGEM

↠ O primeiro exame de imagem a ser solicitado para um paciente com suspeita de espondilite anquilosante é a radiografia convencional de sacroilíacas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: A ressonância é o exame mais sensível para detectar alterações inflamatórias nas espondiloartrites, mas lembre-se de que a definição de espondilite anquilosante envolve, obrigatoriamente, sacroiliíte na radiografia (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Os critérios modificados de Nova York, são utilizados até hoje na padronização dos achados radiográficos em sacroilíacas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 5: Critérios modificados de Nova York para avaliação de sacroiliacas (1994)	
Grau 0	Normal
Grau 1	Alterações suspeitas (borramento da imagem)
Grau 2	Alterações mínimas (perda de definição da articulação, irregularidades, algum grau de esclerose justa-articular)
Grau 3	Alterações evidentes (esclerose, erosões ósseas, irregularidades das margens articulares, alteração do espaço articular)
Grau 4	Anquilose (fusão das superfícies articulares)

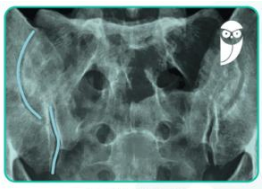


Figura 10: sacroiliaca normal



Figura 11: note a esclerose óssea nas bordas principalmente dos ilíacos associada a irregularidades e alteração do espaço articular.

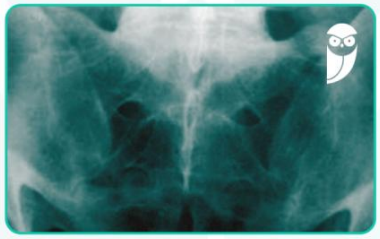


Figura 12: note a ausência de espaço articular bilateral, na topografia, onde deveria estar a articulação sacroilíaca.

Note que em uma sacroilíaca normal (Figura 10), o espaço articular é bem visível e as bordas tanto do sacro quanto do ilíaco são regulares. Já em casos moderados a avançados (Figura 11), uma vez que você conhece a normalidade, rapidamente nota as alterações decorrentes do processo inflamatório, como esclerose e irregularidade nas bordas da articulação, além de alteração no espaço articular. O estágio final da doença é a perda completa do espaço articular ou anquilose (figura 12). Note que não há mais espaço articular visível, apenas a linha de

esclerose na topografia de onde se encontrava a articulação (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 13: note os cantos brilhantes (setas), um sindesmófito formando-se entre L1 e L2 e a perda da concavidade normal de L3 que adquire um formato mais quadrado

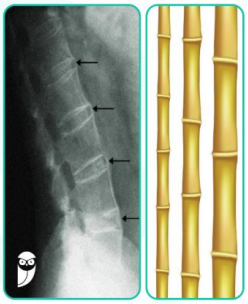


Figura 14: todas as setas apontam para neoformações ósseas finas, verticais e regulares (sindesmófitos) que, ao unirem as vértebras, formam o aspecto de coluna em bambu.



Figura 15: posição do esquiador em paciente com espondilite anquilosante em estágio avançado

Apesar das alterações serem mais frequentes na coluna lombar, os segmentos torácico e cervical também podem ser acometidos e a fusão completa da coluna vertebral é responsável pela clássica posição do esquiador (figura 15), altamente debilitante, mas felizmente pouco vista atualmente devido aos avanços em diagnóstico e tratamento (ESTRATÉGIAMED, 2024).

A lesão mais típica das espondiloartrites axiais em atividade na ressonância magnética é o edema de medula óssea, que pode estar associado à sinovite, entesite e capsulite. Já os achados sugestivos de lesões crônicas são a esclerose óssea e erosões, dentre outros (ESTRATÉGIAMED, 2024).

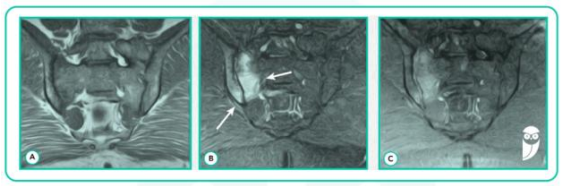


Figura 16: sequência de imagens de ressonância magnética em paciente com espondiloartrite axial. Note o edema de medula óssea (áreas hiperintensas brilhantes) praticamente em toda extensão da sacroilíaca à direita, tanto na borda ilíaca quanto sacral (setas).

Resumindo a evolução natural da espondilite anquilosante caso tratamento adequado não seja instituído: (ESTRATÉGIAMED, 2024).



EXAME FÍSICO

↠ O exame físico do paciente com espondilite anquilosante é muito rico em achados característicos e, por isso, é realizado de forma muito minuciosa (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Para a avaliação do esqueleto axial, dispomos de manobras específicas e, sem dúvidas, o teste de Schober é a mais famosa delas, apesar de não ter boa sensibilidade para o diagnóstico de espondilite em fases precoces da doença (ESTRATÉGIAMED, 2024).

TESTE DE SCHOBER MODIFICADO

O que avalia? Flexão da coluna lombar no plano frontal.

Como é realizado? 1º passo: o examinador faz 2 marcas na linha mediana do dorso do paciente: uma ao nível das espinhas ilíacas póstero-superiores (covinhas de Vênus) e outra 10cm acima. 2º passo: com o paciente realizando flexão lombar máxima e mantendo os joelhos em extensão, o examinador mede a distância entre as linhas feitas anteriormente.

A partir de qual valor considero o teste alterado? Em pacientes jovens e saudáveis, espera-se uma variação de, pelo menos, 5cm. Caso a variação seja inferior a esse valor, temos redução objetiva da flexão lombar que, dentro de um contexto sugestivo, fala a favor do diagnóstico de espondilite.

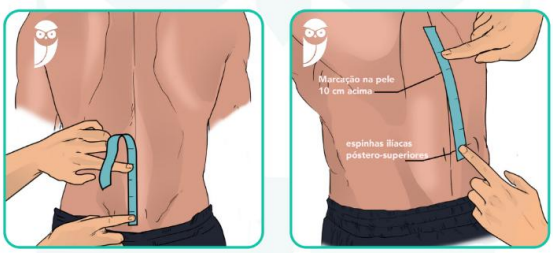


Figura 17: teste de Schober modificado.

↠ A manobra mais conhecida e reproduzida para avaliação das sacroilíacas é a manobra de Patrick, na qual o examinador posiciona o paciente em decúbito dorsal e realiza a flexão, abdução e rotação externa (por isso, também conhecida como FABERE) de um membro inferior por vez, formando um número 4 ao final da manobra. Nesse momento, o examinador estabiliza o quadril contralateral ao membro testado com uma mão e, com a outra, toca a face interna do membro testado levando-o em direção à maca. Dor em região inguinal fala a favor de patologia do quadril, e dor em região lombar contralateral ao membro inferior testado fala a favor de acometimento de articulação sacroilíaca (ESTRATÉGIAMED, 2024).



DIAGNÓSTICO

↠ Os aspectos mais importantes para o diagnóstico da espondilite anquilosante são a clínica compatível e o achado de sacroiliíte na radiografia (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OBS.: A solicitação do HLA-B27 não deve ser feita em caráter de triagem, mas sim dentro de um contexto sugestivo para dar mais força ao diagnóstico. A ausência desse alelo não descarta a possibilidade de espondilite anquilosante, mas torna-a menos provável, especialmente em pacientes brancos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 7: Critérios ASAS para classificação de espondiloartrites axiais (2009)

CRITÉRIO DE ENTRADA

Dor nas costas (lombar, torácica ou cervical) por mais de 3 meses e idade de início da doença até os 45 anos de idade

Sacroiliíte em exames de imagem* e, pelo menos, uma característica de espondiloartrite

OU

HLA-B27 e duas ou mais das características de espondiloartrite

CARACTERÍSTICAS DE ESPONDILOARTRITES

- Lombalgia inflamatória
- Artrite
- Entesite (calcâneo)
- Dactilite
- PCR elevado
- Uveíte
- HLA-B27 positivo
- Boa resposta a anti-inflamatórios não esteroidais
- Psoríase
- Doença inflamatória intestinal
- História familiar de espondiloartrites axiais

* Sacroiliíte na imagem = inflamação aguda sugestiva na ressonância ou sacroiliíte definitiva segundo os critérios modificados de Nova York

TRATAMENTO

↠ O objetivo primário do tratamento da espondilite anquilosante é o controle adequado do quadro inflamatório, o que leva a melhora da dor e rigidez, previne dano estrutural e preserva função e qualidade de vida do paciente a longo prazo. Para isso, ele deve ser multidisciplinar, levando em conta as individualidades de cada caso (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Diversos estudos mostram que a prática de exercícios físicos envolvendo alongamento, fortalecimento e treino aeróbico está associada à melhora clínica e diminui o risco de limitação funcional (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Todos os pacientes fumantes devem ser orientados a cessar o tabagismo por associação direta com atividade da doença (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A primeira linha de tratamento medicamentoso nas espondiloartrites axiais é formada pelos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), que agem inibindo as ciclo-oxigenases e, consequentemente, a produção de prostaglandinas, incluindo a PGE2 diretamente envolvida em sua fisiopatologia (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Inicialmente, para controle adequado da doença, devemos prescrevê-los em dose plena e de forma contínua. Pacientes que mantenham atividade de doença mesmo com uso de dois AINEs diferentes por 2 a 4 semanas cada devem passar para a próxima etapa do tratamento, que envolve o uso de medicamentos imunobiológicos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Os antagonistas do fator de necrose tumoral (anti-TNF) foram os primeiros biológicos aprovados para o tratamento da espondilite anquilosante e seguem sendo seus principais representantes. Atualmente, existem cinco opções e qualquer uma delas pode ser a escolha inicial (infliximabe, adalimumabe, etanercept, certolizumabe e golimumabe) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Na falha ao primeiro anti-TNF, pode-se prescrever outra medicação dessa classe ou trocá-lo por outro imunobiológico com mecanismo de ação diferente. Nesse caso, a opção é pelos inibidores da IL-17A (secuquinumabe) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: O uso de imunossupressores sintéticos, como sulfassalazina e metotrexato, não é indicado para o tratamento das manifestações axiais, mas pode ser feito caso o paciente apresente artrite periférica ou entesite. A infiltração articular com glicocorticoide é uma opção, mas prednisona e equivalentes por via oral não devem ser utilizados de rotina (ESTRATÉGIAMED, 2024).

PROGNÓSTICO

↠ O prognóstico de pacientes com espondilite anquilosante melhorou consideravelmente nos últimos anos e, hoje, a maioria deles apresenta controle adequado da doença, permitindo que mantenham vidas produtivas sem limitações funcionais importantes (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 8: fatores de pior prognóstico na espondilite anquilosante

Sexo masculino	Acometimento precoce de quadril
Tabagismo	Presença prévia de sindesmófitos
Elevação sustentada de provas de atividade inflamatória	Resposta ruim a anti-inflamatórios não esteroidais

Artrite psoriásica

↠ A psoríase é uma doença crônica de pele que ocorre em cerca de 1% a 3% da população adulta mundial e, em cerca de 30% dos casos, está associada a acometimento

articular, recebendo a denominação de artrite psoriásica (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 19: lesões eritemato-descamativas na face extensora dos cotovelos e antebraços típicas da psoríase vulgar ou em placas. (Shutterstock)

↠ A artrite psoriásica é a segunda espondiloartrite mais prevalente, ficando atrás apenas da espondilite anquilosante. É mais frequente em caucasianos, apesar de ser descrita em todos os grupos étnicos, e, na maioria dos estudos, parece afetar homens e mulheres de forma semelhante. Um estudo com a população brasileira encontrou uma maior prevalência, ainda que discreta, em homens (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A maioria dos casos inicia-se entre os 20 e 50 anos, mas a doença pode surgir em qualquer faixa etária, inclusive em crianças (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ETIOLOGIA

A etiologia exata da artrite psoriásica é desconhecida, mas partimos do mesmo pressuposto estabelecido para a espondilite anquilosante, no qual um gatilho ambiental pode desencadear alterações imunológicas em um indivíduo geneticamente predisposto e propiciar o surgimento das manifestações clínicas da doença (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A artrite psoriásica é uma doença poligênica associada a diversos alelos, incluindo o HLA-B27 (presente em 20% a 60% dos casos), especialmente naqueles com envolvimento do esqueleto axial. Até 40% dos pacientes com artrite psoriásica apresentam histórico familiar positivo para essa condição (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Quanto aos possíveis gatilhos ambientais, infecções (ex.: vírus HIV) e traumatismos físicos parecem ser os mais relevantes (ESTRATÉGIAMED, 2024).

FISIOPATOLOGIA

↠ Apesar de ainda não estar completamente elucidada, a fisiopatologia da artrite psoriásica envolve a ação dos gatilhos ambientais descritos sobre os queratinócitos, levando à ativação de populações celulares (ex.: linfócitos e neutrófilos) e liberação de citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, IL-17, IL-22 e IL-23. Uma vez desencadeado esse processo, estabelece-se um círculo vicioso que perpetua a inflamação e os danos causados por ela na pele, articulações e outros órgãos-alvo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Manifestações articulares

↠ O surgimento das manifestações articulares em pacientes com psoríase parece estar associado a doença cutânea com maior tempo de duração e comprometimento ungueal (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A artrite psoriásica é relacionada a todas as formas cutâneas da psoríase (em placas, invertida, pustulosa, gutata, eritrodérmica) e, também, ao acometimento ungueal com lesões típicas, como pitting nails (pequenas depressões puntiformes nas unhas), onicólise, mancha de óleo, hiperqueratose, entre outras (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Em 70% dos casos, a psoríase antecede a artrite, mas em 15% dos pacientes podem surgir concomitantemente. Nos outros 15% restantes, as lesões cutâneas surgem apenas após a artrite, o que é mais frequente em crianças do que em adultos e dificulta muito seu diagnóstico (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A artrite psoriásica é uma doença muito heterogênea em sua apresentação clínica e pode assumir diferentes formas, conforme classificação abaixo: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 9: Apresentação clínica da artrite psoriásica segundo Moll e Wright (1973)

Artrite oligoarticular assimétrica
Poliartrite simétrica
Artrite com envolvimento predominante das interfalangeanas distais
Artrite mutilante
Doença axial predominante

ATENÇÃO: Inicialmente, a maioria dos pacientes apresenta o padrão mais associado às espondiloartrites, de caráter oligoarticular e assimétrico, mas com o passar dos anos parte evolui para uma poliartrite simétrica de pequenas e grandes articulações, semelhante ao padrão encontrado na artrite reumatoide (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OBS.: Um aspecto particular da artrite psoriásica que nos auxilia no diagnóstico diferencial com a artrite reumatoide: o envolvimento das interfalangeanas distais (IFDs) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A dactilite, ou dedo em salsicha, já descrita anteriormente na espondilite anquilosante, é um marco da artrite psoriásica e ocorre nas mãos e pés de até 40% dos pacientes (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Com a progressão da doença, surgem as deformidades e, em estágios avançados, a completa destruição articular caracterizada por erosões, subluxações e reabsorção óssea (artrite mutilante) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Manifestações extra-articulares

↠ Comparada à espondilite anquilosante, a artrite psoriásica apresenta menor frequência de manifestações extra-articulares (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ O envolvimento ocular ocorre principalmente sob a forma de conjuntivite, mas uveíte e episclerite também são descritas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Úlceras orais, uretrite, colite e insuficiência aórtica são possíveis, mas incomuns (ESTRATÉGIAMED, 2024).

EXAMES LABORATORIAIS

↠ Não há exame laboratorial específico da artrite psoriásica, mas, por tratar-se de uma doença de caráter inflamatório crônico, podemos encontrar elevação de PCR e VHS, especialmente em períodos de atividade da doença. Hiperuricemia está presente em cerca de 20% dos pacientes e está associada à disfunção endotelial (ESTRATÉGIAMED, 2024).

	ARTRITE REUMATOIDE	ARTRITE PSORIÁSICA
Associação com HLA-B27	Não.	Sim.
Positividade para fator reumatoide e/ou anti-CCP	Sim! Em geral, altos títulos (70% -80% dos casos).	No máximo, em 10% dos casos e em baixos títulos.
Padrão de acometimento articular	- Poliartrite crônica e simétrica de pequenas e grandes articulações; - Interfalangeanas proximais, metacarpofalangeanas e punhos mais frequentemente afetados.	- Apresentação heterogênea; - Padrões mais comuns: oligoartrite assimétrica e poliartrite simétrica; - Em geral, não acomete metacarpofalangeanas e punhos.
Acometimento de interfalangeana distal	Não.	Sim.
Acometimento de coluna lombar e sacroilíacas	Não.	Sim.
Associação com dactilite e entesite	Não.	Sim.

EXAMES DE IMAGEM

Inicialmente, o processo inflamatório nas articulações periféricas pode levar a alterações comuns a outras artropatias inflamatórias, como aumento de partes moles, erosões ósseas e redução do espaço articular; mas, com a progressão da doença, surgem as alterações radiográficas típicas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Um achado característico e que auxilia no diagnóstico diferencial dessa espondiloartrite é o fato de lesões ósseas proliferativas, mais evidentes em falanges de mãos e pés (periostite com aspecto fluffy ou algodonoso), coexistirem com reabsorção e afilamento ósseo, levando à lesão do tipo pencil-in-cup, além de osteólise, subluxações e, em casos graves, completa destruição articular com encurtamento dos dedos (dedos em telescópio) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

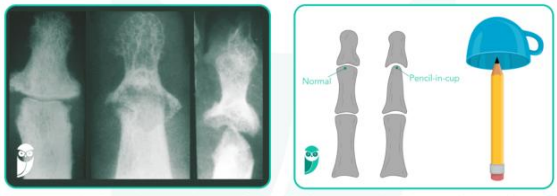


Figura 21: note a proliferação periosteal com aspecto algodonoso na falange distal (círculo) e a progressiva reabsorção óssea nas regiões distais das falanges até o surgimento da lesão pencil-in-cup (seta).

DIGNÓSTICO

↠ Após um grande estudo, o grupo CASPAR (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis) desenvolveu os critérios classificatórios usados atualmente, nos quais três ou mais pontos apresentam alta sensibilidade e especificidade: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 11: Critérios classificatórios para artrite psoriásica segundo CASPAR (2006)	
Psoríase cutânea atual OU História pessoal de psoríase OU História familiar de psoríase	2 pontos 1 ponto 1 ponto
Distrofia ungueal	1 ponto
Dactilite atual ou episódio anterior visto por médico	1 ponto
Fator reumatoide negativo	1 ponto
Neoformação óssea justa-articular na radiografia de mãos e pés	1 ponto

TRATAMENTO

↠ O tratamento não-farmacológico é composto por orientações gerais, como cessação de tabagismo e mudanças de estilo de vida, envolvendo controle de peso e de outros fatores de risco cardiovasculares através de dieta adequada e prática de atividade física (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Pacientes com acometimentos periférico ou axial considerados leves e sem achados radiográficos que denotem dano estrutural podem ser manejados inicialmente com AINEs, desde que não apresentem contraindicação e sejam monitorizados quanto a possíveis eventos adversos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Imunossupressores sintéticos são úteis em casos moderados e/ou que não respondam à terapêutica inicial com AINEs. O metotrexato é a droga de escolha por ser eficaz no controle dos acometimentos cutâneo e articular. Caso se atinja a dose máxima de 25 mg/semana sem a resposta esperada, pode-se associar outro imunossupressor, como leflunomida, sulfassalazina e ciclosporina (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Na falha aos imunossupressores sintéticos ou caso o paciente apresente envolvimento do esqueleto axial sem melhora com uso de AINEs, há indicação de drogas

imunobiológicas e, assim como na espondilite anquilosante, os agentes de primeira escolha são os anti-TNF que tratam pele e articulação (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Artrite reativa

⇾ A artrite reativa é uma condição desencadeada por quadros infecciosos extra- articulares, em geral de origem nos tratos geniturinário e gastrointestinal, na qual não é possível isolar o patógeno no líquido sinovial (estéril) (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ É considerada uma espondiloartrite por compartilhar mecanismos etiopatogênicos e aspectos clínicos com as outras doenças que compõem esse grupo, mas possui características próprias que a tornam muito particular (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OBS.: A síndrome de Reiter (artrite, conjuntivite e uretrite) representa um subgrupo de pacientes com artrite reativa (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ É mais frequente no sexo masculino quando associada a infecções do trato geniturinário (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ETIOLOGIA

⇾ Em indivíduos geneticamente predispostos, a ocorrência de infecções por determinados patógenos gera uma resposta imune disfuncional responsável pelas manifestações clínicas da doença. O principal fator de risco genético para a artrite reativa é a presença do HLA-B27, presente em 60% a 80% dos pacientes com essa espondiloartrite (ESTRATÉGIAMED, 2024).

FISIOPATOLOGIA

⇾ Postula-se que a resposta imune disfuncional se inicie com o processo de apresentação de antígenos aos linfócitos, no qual o alelo HLA-B27 exerce um papel importante (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ A ***Chlamydia trachomatis*** é responsável por 50% dos casos de artrite reativa e acredita-se que até 3% dos pacientes com uretrite por essa bactéria desenvolvam o quadro articular (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tabela 12: principais bactérias do trato gastrointestinal associadas à artrite reativa
Salmonella (*typhimurium, enteritidis*, heidelberg, *choleraesuis*)
Shigella (*flexneri, dysenteriae, sonnei*)
Yersinia (O:3, O:9 e *pseudotuberculosis*)
Campylobacter (*jejuni, coli*)

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

⇾ Em geral, a artrite reativa inicia-se de forma aguda 1 a 4 semanas após a infecção (ESTRATÉGIAMED, 2024).

A artrite reativa pode ter caráter transitório, com a maioria dos casos apresentando resolução clínica de 6 meses a 1 ano. Entretanto, há risco de cronificação, especialmente em indivíduos HLA-B27 positivos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

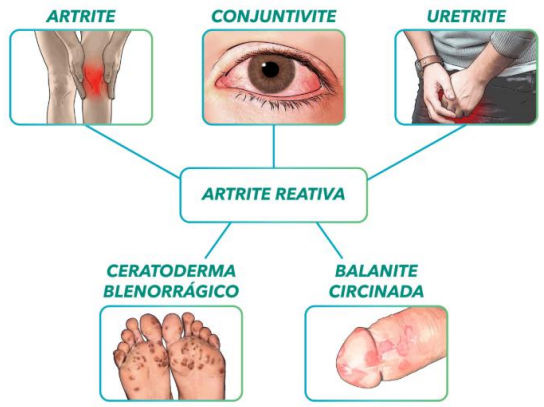
⇾ Sintomas constitucionais inespecíficos podem estar presentes, como febre, mal-estar, fadiga, e vêm acompanhados, em geral, de uma oligoartrite assimétrica predominantemente de membros inferiores (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ Até 40% dos pacientes com artrite reativa apresentam acometimento de esqueleto axial (sacroiliíte e/ou espondilite) e apresentam queixas como lombalgia de caráter inflamatório, com forte associação ao HLA-B27. Entesite e dactilite são comuns durante o curso da doença (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ A conjuntivite estéril é a manifestação extra-articular mais frequente (ESTRATÉGIAMED, 2024).

QUADRO CLÍNICO CLÁSSICO DA ARTRITE REATIVA

Paciente adulto jovem que apresenta diarreia ou infecção de trato geniturinário e, 1 a 4 semanas depois, desenvolve oligoartrite de membros inferiores associada a manifestações extra-articulares (conjuntivite, uretrite, lesões muco-cutâneas) (ESTRATÉGIAMED, 2024).



EXAMES COMPLEMENTARES

⇾ Não há nenhum exame específico de artrite reativa. Pode haver elevação de provas de atividade inflamatória (PCR e VHS) e evidência de infecção prévia por cultura, sorologia ou investigação molecular, mas não há obrigatoriedade desses achados para estabelecer o diagnóstico (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Júlia Morbeck – @med.morbeck

⇾ A punção articular revela um líquido sinovial de caráter inflamatório com celularidade entre 2.000/mm3 a 50.000/mm3 (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ Ressonância magnética e ultrassonografia mostram alterações inflamatórias agudas compatíveis com artrite e entesite e, nos casos crônicos, a radiografia convencional mostra as sequelas desse processo, como redução do espaço articular e erosões (ESTRATÉGIAMED, 2024).

DIAGNÓSTICO

⇾ O diagnóstico da artrite reativa é clínico e, até o momento, não há critérios bem definidos a serem aplicados aos pacientes (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OBS.: O principal diagnóstico diferencial da artrite reativa é a artrite gonocócica por ambas acometerem adultos jovens, estarem associadas a queixas de trato geniturinário e a manifestações extra-articulares (ESTRATÉGIAMED, 2024).

	ARTRITE REATIVA	ARTRITE GONOCÓCICA
Sexo	Homem = Mulher (H>M se infecção de trato geniturinário)	Mulher > Homem
Artralgia migratória precedendo o surgimento das manifestações clínicas	Não	Sim (descrita na maioria dos casos)
Artrite	Predomínio em joelhos, tornozelo e pé	Predomínio em mão, punho e joelho
Entesite e dactilite	Sim	Não
Acometimento do esqueleto axial	Sim	Não
Lesões mucocutâneas mais típicas	Ceratoderma blenorrágico Balanite circinada	Pústulas em extremidades e tronco
Cultura de líquido sinovial	Negativa	Positiva em até 50% dos casos

TRATAMENTO

⇾ Inicialmente, pacientes com acometimento periférico e/ou axial devem receber AINEs, com boa resposta na maioria dos casos. Infiltração articular com glicocorticoides pode ser útil em casos com boa resposta à terapia sistêmica, mas com persistência dos sintomas em uma articulação (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ Pacientes que apresentem sintomas por mais de 6 meses, apesar do uso de AINEs e glicocorticoides, são classificados como tendo a forma crônica da doença e devem ser manejados de forma diferente. Pacientes crônicos com quadro periférico refratário apresentam indicação de imunossupressores sintéticos, como sulfassalazina e metotrexato. Se após 3 a 4 meses de uso dessas medicações em doses otimizadas não houver melhora clínica, ou frente a pacientes com predomínio de acometimento axial, devemos iniciar um imunobiológico da classe dos inibidores do TNF (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Artrite associada à doença inflamatória intestinal (artrite enteropática)

⇾ Manifestações articulares associadas à doença de Crohn e à retocolite ulcerativa, mas é importante que você saiba que não são apenas as doenças inflamatórias intestinais que causam artrite (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 22: figura esquemática mostrando o acometimento típico da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa.

O acometimento articular parece ser a manifestação extraintestinal mais frequente das doenças inflamatórias intestinais e sua prevalência estimada está em torno de 0,2% da população mundial (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ETIOLOGIA

⇾ Nas doenças inflamatórias intestinais ocorre alteração da permeabilidade de mucosa, o que permite maior translocação bacteriana e, uma forte hipótese etiológica para as espondiloartrites envolve a resposta imune disfuncional à presença de antígenos "estranhos" derivados de patógenos. Soma-se a isso o fato de as doenças inflamatórias intestinais compartilharem alguns marcadores genéticos com as espondiloartrites, como polimorfismos associados a receptores das interleucinas 17 e 23 (ESTRATÉGIAMED, 2024).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

⇾ Assim como ocorre na artrite psoriásica, os sintomas articulares podem preceder as queixas gastrointestinais em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Por isso, apesar de dor abdominal, diarreia, sangramento e sintomas constitucionais acenderem o sinal de alerta, qualquer paciente apresentando queixas articulares de caráter inflamatório, sejam periféricas ou axiais, deve ter artrite enteropática como hipótese diagnóstica (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ Com relação ao acometimento periférico, há uma divisão clássica entre tipos I e II segundo os critérios de

Oxford, mas a tendência atual é não se apegar tão fortemente a essa classificação, já que são apenas espectros diferentes de uma mesma manifestação (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Tipo I: oligoartrite assimétrica predominando em grandes articulações de membros inferiores (joelho e tornozelo) de caráter não erosivo. É a forma mais comum, autolimitada na maioria dos casos e associada à atividade inflamatória intestinal;
- Tipo II: poliartrite simétrica acometendo pequenas e grandes articulações em padrão semelhante ao encontrado na artrite reumatoide, inclusive com a possibilidade de erosões e deformidades. É menos frequente e costuma ter evolução independente da atividade da doença inflamatória intestinal.

↠ O envolvimento axial é mais frequente na doença de Crohn e pode surgir isoladamente ou em associação às manifestações periféricas. Pode ser assintomático e diagnosticado apenas em exames de imagem ou cursar com lombalgia de caráter inflamatório, característica das espondiloartrites (ESTRATÉGIAMED, 2024).

	ESPONDILITE ANQUILOSANTE E ARTRITE ENTEROPÁTICA	ARTRITE PSORIÁSICA E ARTRITE REATIVA
Sacroilíite	Bilateral e simétrica	Unilateral ou assimétrica
Coluna vertebral	Sindesmófitos finos, regulares e com orientação vertical	Sindesmófitos grosseiros, irregulares e assimétricos

EXAMES COMPLEMENTARES

↠ Não há nenhum marcador específico de artrite enteropática e achados laboratoriais, como anemia, leucocitose e elevação de provas de atividade inflamatória, são frequentemente encontrados em paciente com doenças inflamatórias intestinais e são de pouca ajuda no diagnóstico específico da artrite (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ No caso da artrite enteropática, o HLA-B27 está presente em maior frequência nos pacientes que apresentam acometimento do esqueleto axial (ESTRATÉGIAMED, 2024).

DIAGNÓSTICO

↠ Na ausência de critérios classificatórios e exames específicos, para diagnosticarmos artrite enteropática devemos ter alto nível de suspeição e valer-nos da boa e velha clínica médica auxiliados por exames complementares (ESTRATÉGIAMED, 2024).

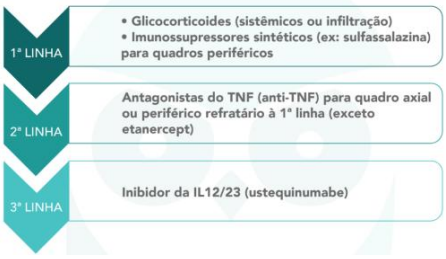
TRATAMENTO

↠ Para sucesso no tratamento dos pacientes com artrite enteropática, é fundamental estabelecermos seguimento conjunto entre o reumatologista e o gastroenterologista, além de suporte físico, nutricional, psicológico, dentre outros que se façam necessários (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) estão associados à exacerbação da doença inflamatória intestinal (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A sulfassalazina funciona como um coringa por ser eficaz no manejo das queixas intestinais e articulares, mas outras drogas, como o metotrexato, também surgem como opções (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Na falha aos imunossupressores ou em pacientes que apresentem predomínio de acometimento axial, devemos indicar drogas imunobiológicas, preferencialmente os anti-TNF (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Artropatias

OBS.: Dizer que uma doença é mecânica significa dizer que ela se relaciona com movimento/forças físicas ou é causada por eles (REZENDE; CAMPOS, 2013).

Osteoartrite

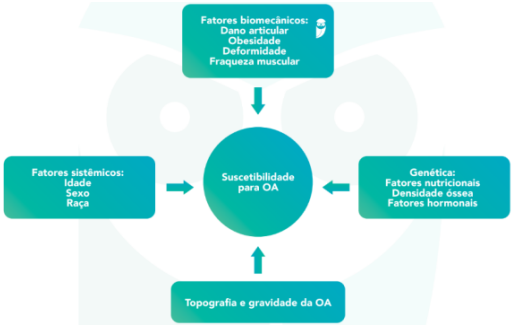
↠ A osteoartrite (OA) é a forma mais comum de artrite. É considerada um problema de saúde pública, pois pode gerar incapacidade e afastamento do trabalho (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A prevalência da OA aumenta com a idade, sendo incomum encontrarmos em alguém com menos de 40 anos, sendo mais frequente acima dos 60 anos. Após os 75 anos, 85% das pessoas têm evidência de OA radiográfica. É predominante no sexo feminino (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ As articulações mais frequentemente acometidas, além de quadril e joelhos, são as das mãos, com predileção pelas interfalangeanas distais, proximais e da

base do polegar, da coluna cervical e da lombar e as primeiras metatarsofalangeanas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

FATORES DE RISCO



- Idade avançada: é o principal fator de risco geral para a doença. Ocorre formação de colágeno com pior qualidade e menor elasticidade.
- Sexo feminino: especialmente quando falamos de OA de mãos e joelho. Já a osteoartrite de quadril é mais comum no sexo masculino até os 50 anos de idade.
- Raça: é um fator que depende da articulação. Sabe-se que, em negros, a OA de joelhos é mais grave quando comparada aos brancos, assim como OA de quadril é rara em chineses.
- Predisposição genética: a OA nodal de mãos com formação dos nódulos de Heberden e Bouchard apresenta risco de 2-3x maior entre parentes de primeiro grau quando comparado com a população geral. Além disso, os nódulos de Heberden estão associados ao HLA-B18, HLA-B8 e A1.
- Obesidade: a maioria dos sítios aumenta a probabilidade de desenvolvimento de OA, inclusive articulações que não são envolvidas diretamente com carga. Isso é reflexo da produção de adiponectinas (citocinas pró-inflamatórias). É o principal fator de risco, se analisada a progressão da doença, além de ser também o principal fator de risco modificável.
- Trauma prévio: como lesões de menisco ou fraturas podem levar ao desalinhamento articular, provocando OA.
- Alterações mecânicas: presentes em deformidades como varo ou valgo, além de displasia de quadril, por exemplo.
- Tabagismo: pode contribuir para doença discal, por exemplo.

CLASSIFICAÇÃO

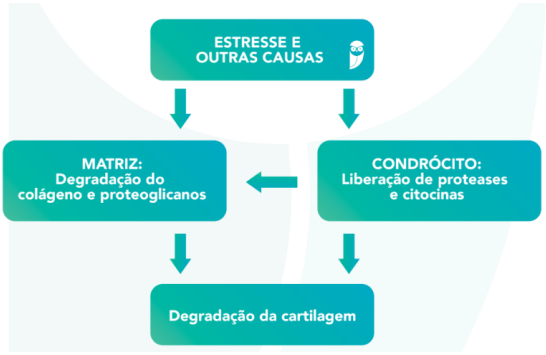
↠ Na maioria dos casos, a OA aparece de modo insidioso, sem causa desencadeante aparente, como fenômeno do envelhecimento (OA idiopática ou primária). Nesses casos, a doença normalmente afeta poucas articulações (oligoarticular), mas pode ser generalizada (KUMAR et al., 2023).

↠ Em cerca de 5% dos casos, a OA aparece em indivíduos mais jovens com condições predisponentes, como deformidade articular, lesão articular anterior ou doença sistêmica subjacente, como diabetes melito, ocronose, hemocromatose ou obesidade acentuada, que coloca em risco as articulações. Nesses contextos, a doença é denominada OA secundária (KUMAR et al., 2023).

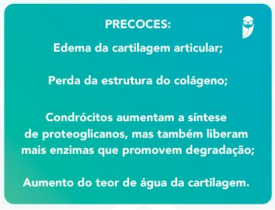


PATOLOGIA

↠ O principal processo envolvido é a quebra da homeostase entre degradação e reparação, ocorre um aumento considerável do metabolismo celular articular em reposta a uma agressão à cartilagem (ESTRATÉGIAMED, 2024).



↠ No processo fisiopatológico ocorre alterações precoces e tardias: (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Júlia Morbeck – @med.morbeck

TARDIAS:

As enzimas de degradação quebram os proteoglicanos mais rápido que o condrócito consegue produzir, gerando redução dessa matéria na cartilagem;

A cartilagem articular passa a ficar mais fina e mole (à radiografia é possível observar o estreitamento do espaço articular);

Ocorre fissura e quebra da cartilagem com tentativa de reparo, porém inadequado;

O osso subcondral é exposto, permitindo que o líquido sinovial seja forçado pela pressão do peso para dentro do osso, isso explica a formação dos cistos ósseos na radiografia;

Remodelamento e hipertrofia do osso, resultando em esclerose subcondral e osteófitos.

↠ A história evolutiva do processo leva à neoformação da matriz da cartilagem, que pode levar à formação de osteófitos, que são estruturas de cartilagem calcificada desprovidos de função fisiológica. No osso subcondral, inicialmente, há aumento da densidade óssea, por neoformação, chamada à radiologia de esclerose. Numa fase mais tardia, podem surgir áreas de fissuras e erosões extensas capazes de expor o osso subcondral, ao lado de segmentos de intensa atividade metabólica na cartilagem remanescente. Outras estruturas, como a cápsula articular e os ligamentos, podem sofrer estiramento por tração e edema, bem como a musculatura periarticular (ESTRATÉGIAMED, 2024).

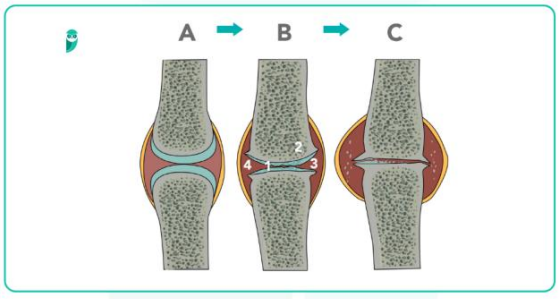


Figura 02: Representação de uma articulação normal (A) com o espaço preservado entre as estruturas ósseas, aqui não há alteração do colágeno. Em B, temos uma articulação com redução da espessura da cartilagem (1), aumento reacional do osso subcondral (2), formação de osteófitos (3) e sinovite de pequena magnitude (4). Em C, observa-se a fase terminal da OA com perda quase total do espaço articular e desgarramento de debris osteocartilaginosos, que provocam piora do processo inflamatório.

QUADRO CLÍNICO

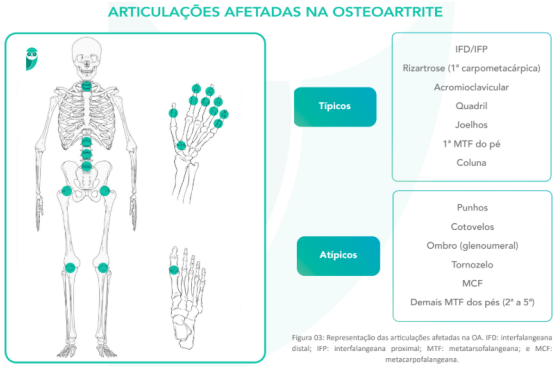


Figura 03: Representação das articulações afetadas na OA. IFD: interfalangeana distal; IFP: interfalangeana proximal; MTF: metatarsofalangeana; e MCF: metacarpofalangeana.

SINTOMAS
Dor articular relacionada ao uso
Rigidez matinal efêmera/fugaz (menor que 30 minutos)
Dor no início do movimento (protocinética)
Parestesias e disestesias
Melhora ao repouso
SINAIS
Dor e sensibilidade à mobilização, palpação ou manobras
Crepitação palpável e às vezes audível
Espasmo e atrofia da musculatura articular satélite
Limitação da amplitude de movimento, em geral sem anquilose
Mau alinhamento articular
Derrame articular, comumente relacionado a trauma ou uso excessivo da articulação
Sinais discretos de inflamação articular
Presença de nódulos de Heberden e Bouchard

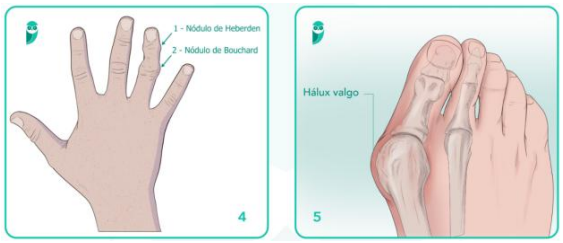
OBS.: OA de mãos nodal, a denominamos assim quando ocorre aumento de volume nas interfalangeanas distais (nódulos de Heberden) e proximais (nódulos de Bouchard). Esses nódulos correspondem à hipertrofia óssea (osteófitos) lateral e dorsal. Ainda, há um subtipo da nodal que apresenta um padrão mais inflamatório, que denominamos OA erosiva (ou nodal erosiva), aparece habitualmente de forma aguda, dolorosa e simétrica, comprometendo predominantemente as IFP e as IFD. Esse tipo é mais comum no sexo feminino, período climatérico, com componente familiar frequente. Aqui, a radiografia pode mostrar até erosões epifisárias e deformidade em "asa de gaivota" (ESTRATÉGIAMED, 2024).

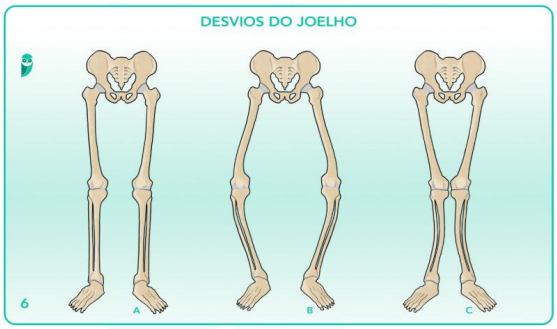
↠ Para o diagnóstico, o achado obrigatório é a presença de dor, associada à epidemiologia compatível e aos fatores de risco. Além disso, pode haver dissociação clínico-radiológica, ou seja, não podemos esperar alterações na radiografia para fazer o diagnóstico e não necessariamente uma radiografia alterada vai ser compatível com dor na história clínica (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: A cartilagem é aneural, Isso mostra que a origem não vem da cartilagem em si, na verdade há outras estruturas que têm seus nociceptores estimulados pela própria tração mecânica que sofrem ou por substâncias inflamatórias liberadas localmente, a exemplo da prostaglandina E2. E quais são essas estruturas? Ênteses, ligamentos, osso subcondral, cápsula articular e membrana sinovial. Todos são bem inervados e contribuem para a ativação de vias dolorosas aferentes nociceptivas medulares, gerando até alodinia e hiperalgesia. Inclusive, essa também é a explicação para a utilização da duloxetina na OA (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Algumas alterações são importantes ao exame físico, pois podem corroborar o diagnóstico. Pode ocorrer aumento de volume articular, calor local, crepitações e limitações ao movimento passivo da articulação, além disso, deve-se avaliar possíveis instabilidades articulares decorrentes de fragilidade de ligamentos e/ou músculos. Sensação de click ou instabilidade são muito relatados pelos pacientes e possivelmente indicam lesão meniscal, pode ocorrer na OA de joelho, por exemplo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Varismo e valgismo dos joelhos, valgismo do hálux, desvio dos dedos das mãos com formação dos nódulos de Heberden e Bouchard também são comuns (ESTRATÉGIAMED, 2024).





Na figura 04, mostramos os nódulos de Heberden (interfalangeanas distais) e Bouchard (interfalangeanas proximais) na OA. Figura 05 mostrando a deformidade tipo hálux valgo e figura 06 mostrando em A: joelho sem deformidade; B: geno varo; e C: geno valgo.

EXAMES COMPLEMENTARES

↠ Exames laboratoriais específicos não são necessários para o diagnóstico da OA. Lembre-se que a doença não tem origem autoimune, logo não vamos esperar produção de anticorpos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Exames de imagem não são fundamentais, ainda mais quando estamos diante de uma articulação tipicamente acometida pela doença acompanhada de história clínica/epidemiologia compatíveis. Quando estivermos frente a articulações atípicas, a radiografia torna-se valiosa para efeito de diagnóstico diferencial (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 07: perceba, em todas as radiografias, a intensa redução de espaço articular. Em A, temos o achado clássico da OA de mãos, representado pela depressão central do osso, gerando o aspecto de asa de gaivota, além de esclerose subcondral e cistos subcondrais. Em B, temos a rizartrose (OA da primeira carpometacárpica). Em C, representamos OA coxofemoral com intensa redução de espaço articular.

↠ A radiografia simples vai revelar os seguintes achados clássicos: esclerose do osso subcondral, osteofitose, redução e desalinhamento do espaço articular, cistos e áreas de erosão (ESTRATÉGIAMED, 2024).

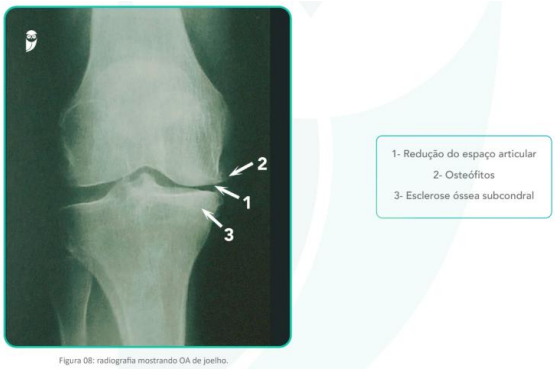


Figura 08: radiografia mostrando OA de joelho.

↠ A ultrassonografia pode mostrar derrame articular e edema sinovial, podendo eventualmente ser útil no diagnóstico diferencial (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A ressonância magnética é mais sensível em mostrar alterações precoces, como edema do osso subcondral (bone marrow lesions – BML) e alterações meniscais, além de derrame articular mesmo leve e alterações da cartilagem. Entretanto, geralmente não altera a orientação da conduta, não sendo recomendada uma solicitação na rotina (ESTRATÉGIAMED, 2024).



TRATAMENTO

↠ Os objetivos incluem alívio sintomático e melhora da mobilidade, uma vez que não há estratégias que, de forma inequívoca, impeçam a progressão do dano estrutural à junta (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Não farmacológico

↠ Alguns estudos mostraram impacto na queixa de dor quando houve redução de 10% do peso corporal, sendo assim, é fundamental orientar os pacientes com sobrepeso uma dieta adequada. A prática rotineira de exercícios reduz o esforço em tendões e ligamentos e a sobrecarga à cartilagem e ao osso subcondral, além disso,

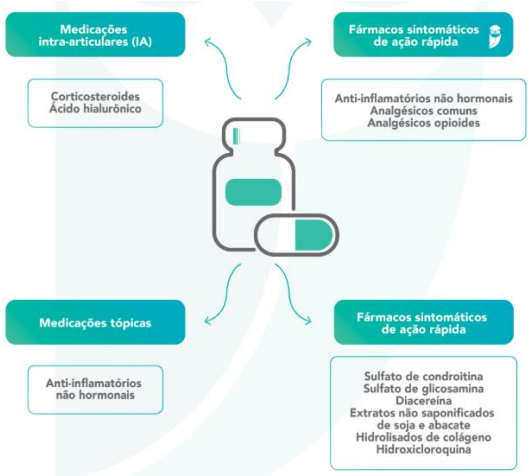
é capaz de prevenir o dano às articulações, decorrente de esforço físico sob musculatura frágil (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Os exercícios na água geralmente são mais bem tolerados pelos pacientes e são capazes de aliviar a dor, além disso ampliam a mobilidade e fortalecem os músculos. As práticas de alongamento por si só não demonstraram benefício, mas são habitualmente incluídos no início de atividade física (ESTRATÉGIAMED, 2024).

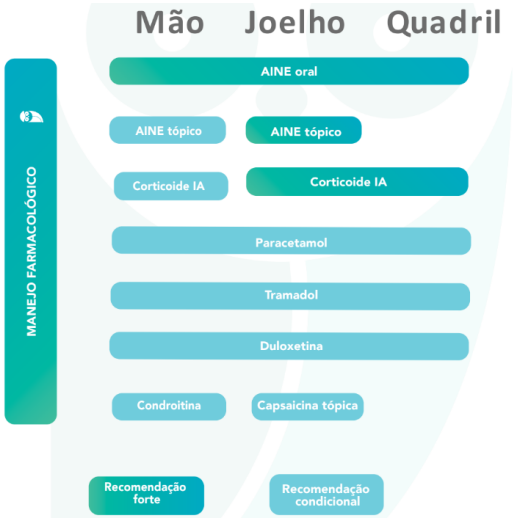
↠ Tratamentos que aumentam a temperatura intra-articular, como diatermia de micro-ondas e ondas curtas, calor superficial e ultrassom, não são adequados na artrite ativa, pois sabe-se que a atividade enzimática responsável pela degradação cartilaginosa aumenta com a temperatura. Já a redução da temperatura intra-articular pode ser realizada com aplicação de gelo por períodos de 15 a 20 minutos. A melhor indicação do calor é para casos de contratura muscular sem artrite ativa (ESTRATÉGIAMED, 2024).

MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS NO TRATAMENTO DA OA
Educação e apoio psicológico
Exercícios e repouso
Atividades da vida diária e ocupacionais
Proteção articular
Dieta/controle de obesidade
Órteses
Fisioterapia

Farmacológico



↠ O Colégio Americano de Reumatologia (ACR) publicou em 2020 recomendações para o tratamento da OA de quadril, mãos e joelhos, estratificando as medicações em fortemente recomendadas ou condicionalmente recomendadas (deve sempre ser avaliada a condição clínica e pesar risco benefício) (ESTRATÉGIAMED, 2024).



↠ Além disso, o ACR também coloca uma lista de medicações em que NÃO recomenda o uso: (ESTRATÉGIAMED, 2024).



FÁRMACOS SINTOMÁTICOS DE AÇÃO RÁPIDA: Para analgesia comum, recomenda-se o paracetamol como droga de escolha (ESTRATÉGIAMED, 2024).

MEDICAÇÕES INTRA-ARTICULARES (IA): O uso de corticosteroides é visto na prática clínica, apesar da controvérsia, apresentando resposta variada a depender do paciente. É capaz de aliviar a dor e o desconforto para deambular por, em média, três semanas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OUTROS: A duloxetina encontra indicação na OA, uma vez que está relacionada à modulação das vias inibitórias da dor endógena por meio da inibição seletiva da recaptação da serotonina e norepinefrina. Os pacientes com acometimento poliarticular e comorbidades concomitantes que podem contraindicar o uso de AINEs orais ou aqueles que não responderam satisfatoriamente aos AINEs podem ser beneficiados com o uso da droga (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Tratamento cirúrgico

↠ A artroplastia total é a terapia com melhor resultado em OA de joelhos e quadril. É indicada quando o tratamento conservador é ineficaz em pacientes com dor prolongada ou permanente naqueles que começam a desenvolver deformidades fixas ou perda da função articular e não tiveram resposta satisfatória diante de um tratamento otimizado durante 3 a 6 meses. Desbridamento articular cirúrgico não encontra indicação, pois há estudos mostrando resultados semelhantes a placebo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Artrites infecciosas

↠ Todos os tipos de microrganismos podem se estabelecer em articulações durante a disseminação hematogênica. As estruturas articulares também podem ser infectadas por inoculação direta ou por propagação contígua a partir de um abscesso de tecido mole ou foco de osteomielite. Como a cartilagem, diferentemente do osso, tem uma capacidade regenerativa limitada, a rápida destruição articular, quando ocorre, pode levar a deformidades permanentes (KUMAR et al., 2023).

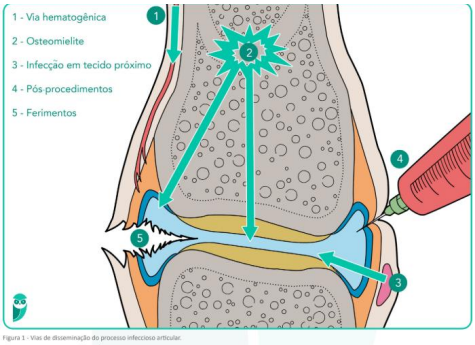
Artrites bacterianas agudas

↠ A artrite séptica representa uma infecção na articulação. Sendo assim, ocorre um processo inflamatório sinovial de caráter supurativo que é causa, inclusive, de artrite aguda destrutiva. Geralmente, é causada por bactéria, mas pode ser decorrente de infecção por qualquer micro-organismo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: Constitui uma emergência médica, pois o atraso no diagnóstico e no tratamento pode gerar danos irreparáveis às estruturas articulares (ESTRATÉGIAMED, 2024).

MECANISMO DA INFECÇÃO

↠ Existem vários mecanismos pelos quais as bactérias podem adentrar a articulação. Os principais reconhecidos são os seguintes: (ESTRATÉGIAMED, 2024).



1) **Hematogênico**, devido a uma infecção distante (70%);
2) Disseminação devido à **osteomielite** adjacente (especialmente em crianças);
3) **Disseminação linfática**, por conta de infecção de um tecido mole perto da articulação;
4) **Infecções iatrogênicas** por artrocentese ou artroscopia (20%); e
5) **Trauma** penetrante por objetos contaminados.

Dentre essas possibilidades, a principal forma é a disseminação hematogênica através da membrana sinovial, que não possui membrana basal limitante, permitindo que os organismos entrem no espaço articular. Além disso, esse mecanismo é mais comumente causado por organismos com propensão a aderir aos tecidos sinoviais, como o *Staphylococcus aureus*. Essa via é mais comum em grandes articulações também (ESTRATÉGIAMED, 2024).

FATORES DE RISCO

Condições que geram alteração na imunidade do hospedeiro
Neoplasia
Idosos (> 80 anos) ou crianças (< 5 anos)
Doenças crônicas - etilismo, diabetes, cirrose, doença renal crônica, HIV
Úlceras cutâneas ou infecções de pele
Anemia falciforme - suscetibilidade a germes encapsulados
Hipogamaglobulinemia - suscetibilidade à infecção por *Mycoplasma*
Agentes imunossupressores (sintéticos, imunobiológicos, glicocorticoides, quimioterápicos, por exemplo)
Inoculação direta
Abuso de drogas injetáveis
Realização de procedimentos invasivos na articulação ou estruturas periarticulares
Dano articular
Prótese articular (mais de 50% ocorrem em paciente com mais de 70 anos)
Doenças articulares (artrite reumatoide, hemocromatose, osteoartrite, por exemplo)

ETIOLOGIA

↠ Vários patógenos são capazes de causar artrite séptica. A microbiologia da artrite séptica depende, em parte, do mecanismo de infecção e das exposições epidemiológicas em questão (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Agente	Condição do hospedeiro
Staphylococcus aureus	Adultos saudáveis, lesões cutâneas, dano articular prévio, próteses
Streptococcus	Adultos saudáveis, disfunção esplênica
Neisseria gonorrhoeae	Adultos saudáveis, jovens e sexualmente ativos. Tenossinovite, pústulas, poliartrite
Bactérias aeróbias Gram-negativas	Imunossuprimidos, história de infecção do trato gastrointestinal
Bactérias anaeróbias Gram-negativas	Imunossuprimidos, história de infecção do trato gastrointestinal
Micobactérias	Imunossuprimidos, história epidemiológica compatível
Haemophilus	Mais comum em crianças

OBS.: O *Staphylococcus aureus* é a causa mais comum de artrite séptica, porém, quando olhamos separadamente para os adultos jovens sexualmente ativos, *Neisseria gonorrhoeae* é o agente etiológico mais frequente (ESTRATÉGIAMED, 2024).

QUADRO CLÍNICO



Artrite séptica bacteriana não gonocócica

↠ O principal agente aqui é *Staphylococcus aureus*. Do ponto de vista articular, o joelho é a articulação mais

frequentemente acometida e a apresentação clínica clássica é monoarticular (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ A artrite piogênica causada por *S. aureus* pode ocorrer em qualquer idade e pode ser precedida por infecção de pele ou trauma local. Em alguns casos, notamos a instalação súbita de febre, geralmente acima de 38 ºC, e pode haver calafrios e queda do estado geral. Do ponto de vista articular, temos dor, calor, rubor e edema de uma única articulação, com tendência a grandes articulações acompanhados de bloqueio articular ao exame físico (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Artrite séptica bacteriana gonocócica

⇾ Teremos um paciente jovem, geralmente na segunda ou terceira décadas de vida, sexualmente ativo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ A disseminação é hematogênica, após contato sexual, e pode acompanhar, inclusive, infecção sexualmente transmissível, que nem sempre será detectada clinicamente (ESTRATÉGIAMED, 2024).

⇾ Na apresentação dos sintomas, há predominância dos seguintes achados: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Achados na IGD	
Dermatite	75%
Poliartralgia migratória	70%
Tenossinovite	67%
Febre	63%
Artrite purulenta	42%
Sintomas geniturinários	25%

Forma bacteriêmica	Artrite supurativa
É a forma mais comum	Menos comum
Tríade de dermatite, tenossinovite e poliartrite	Mono ou oligoartrite de grandes articulações
Podem ocorrer febre e calafrio	Geralmente, o paciente está afebril

DIAGNÓSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES

⇾ O exame complementar mais importante neste contexto é a análise do líquido sinovial obtido através da punção articular, preferencialmente antes do início da antibioticoterapia (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: Idealmente, toda monoartrite aguda deve ser puncionada devido à possibilidade de artrite séptica (ESTRATÉGIAMED, 2024).



IMPORTANTE: Leucócitos acima de 50.000/mm3 e predominância de polimorfonucleares são a regra quando falamos de artrite séptica (ESTRATÉGIAMED, 2024).

TIPO DE LÍQUIDO	APARÊNCIA	CONTAGEM CELULAR/MM³	PORCENTAGEM DE POLIMORFONUCLEARES (%)	ETIOLOGIA EXEMPLOS
Normal	Claro, viscoso	0-200	< 10	
Não inflamatório	Claro a discretamente turvo, com redução da viscosidade	200-2.000	< 20	Trauma Osteoartrite
Inflamatório	Discretamente turvo, com redução da viscosidade	2.000-50.000	20-75	AR Espondiloartrites Artrites microcristalinas
Infeccioso	Turvo, baixa viscosidade, purulento (em alguns casos)	> 50.000 a 100.000	> 75	Artrite séptica

Há algumas contraindicações relativas para a punção articular, como: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Diátese hemorrágica (por exemplo, hemofilia);
- Trombocitopenia grave;
- anticoagulação (seguro puncionar com INR até 3,5 ou 4,5, a depender da fonte utilizada);
- Celulite periarticular;
- Bacteremia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL





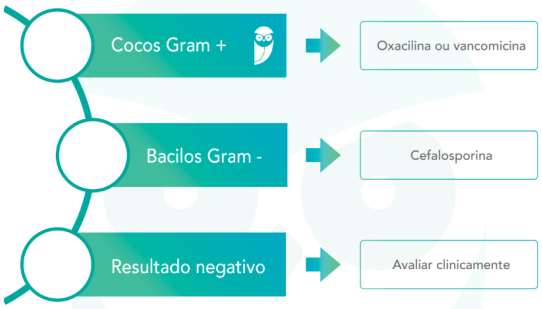
Júlia Morbeck – @med.morbeck

TRATAMENTO

↠ O tratamento adequado já começa com o primeiro passo, que é o seguinte: TODA MONOARTRITE AGUDA DEVE SER PUNCIONADA (ESTRATÉGIAMED, 2024).

O diagnóstico de certeza será dado apenas com a punção. Na maioria dos casos, a drenagem é feita por meio da artrocentese; no entanto, em casos específicos, ela pode acontecer em ambiente cirúrgico (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ O segundo passo é a escolha da antibioticoterapia, que deve ser guiada, inicialmente, pelo Gram, uma vez que a cultura leva mais tempo. A antibioticoterapia empírica é endovenosa e poderá ser convertida para via oral se o quadro clínico evoluir de forma favorável, desde que observado o tempo mínimo de 2 semanas. De maneira geral, deve ser mantida por 2 a 3 semanas para H *influenzae*. Já quando o agente é *S aureus* ou são germes Gram-negativos, deve ser mantida por 3 a 4 semanas (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Quando encontramos cocos Gram-positivos, devemos saber se são sensíveis ou não à meticilina. Para os casos de *S aureus* meticilina sensível, a droga de escolha é a oxacilina (2 g, EV, 4/4h). Para pacientes com *S aureus* meticilina resistente (MRSA), recomenda-se a vancomicina (15 a 20 mg/kg/dose, EV, a cada 8 ou 12 h), tendo como opções alternativas a linezolida ou a clindamicina. (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Em casos de bacilo Gram-negativo, as cefalosporinas de 3ª geração, como a ceftriaxona, são as drogas de escolha. Nos casos suspeitos de *P. aeruginosa*, a opção inicial é ceftazidima ou cefepime combinado com ciprofloxacino ou aminoglicosídeo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

A terapia inicial empírica, em geral, é feita com oxacilina para pacientes imunocompetentes ou com vancomicina associada à cefalosporina de 3ª geração antipseudomonas (ceftazidima ou cefepime), se imunossuprimidos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Artrites bacterianas crônicas

↠ O processo inflamatório aqui é lento e os micro-organismos atingem a articulação por via hematogênica, linfática ou por contiguidade (ESTRATÉGIAMED, 2024).

TUBERCULOSE: Causada por Mycobacterium tuberculosis (MT). O curso da sinovite tuberculosa é insidioso, com poucos sinais flogísticos, e a progressão para dano articular é mais lenta, visto que não há produção de colagenase aqui. O início é insidioso e monoarticular. A TB osteoarticular tem uma tendência a acometer articulações que suportam peso. Entre as articulações periféricas, as mais comuns são quadril, joelho e cotovelo. O esquema básico é feito com RHZE (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) por 2 meses, seguido de RH durante 4 meses (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Acometimento	Fisiopatologia	Manifestações	Evolução
Vertebral	Hematogênica	50% dos casos osteoarticulares Dor na região vertebral toracolombar, espasmo e rigidez muscular. Febre e perda de peso em 40% dos casos	Deformidade (cifose), paraparesia e paraplegia
Articular	Hematogênica ou continuidade de outros órgãos ou ossos	Monoartrite insidiosa, mais frequente quadril, joelho e sacroilíacas	Deformidade e prejuízo de crescimento, necessidade de artrodese ou artroplastia
Osteomielite	Hematogênica	2 a 3% dos casos, início insidioso, acometimento unifocal em fêmur e tíbia	Deformidade
Doença de Poncet	Artrite reacional em casos de TB pulmonar	Poliartrite simétrica de pequenas articulações, febre e eritema nodoso	Resolução com tratamento da TB sem sequelas ósseas

HANSENÍASE: Essa micobacteriose é causada por *Mycobacterium leprae*. O quadro articular costuma responder bem com baixas doses de glicocorticoide. Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) também podem ser utilizados (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Artrites virais

↠ As artrites virais devem ser consideradas em todo paciente com acometimento agudo, poliarticular, autolimitado e com duração de poucas semanas, geralmente menor que 6 semanas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

O curso pode tornar-se prolongado ou crônico, como na artropatia causada pelo vírus da Chikungunya, por exemplo, mas não é o habitual (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Vírus	Clínica
Parvovírus B19	12% dos casos, de **instalação aguda de poliartralgia ou de poliartrite.** Infecção é leve em crianças; destas, 10% têm artralgia e 5% artrite, enquanto nos adultos, 78% têm **artralgia semelhante à artrite reumatoide** com rigidez matinal. Sintomas **limitados a duas semanas** de duração, geralmente. Outros achados: aplasia de medula, anemia hemolítica, perdas fetais, supressão medular, vasculite e hepatite.
Rubéola	Sintomas articulares predominam em mulheres **uma semana antes ou até mesmo concomitante ao *rash* do vírus.** Artralgia é mais frequente do que artrite, costuma ser **simétrica, migratória e com preferência por pequenas articulações.** O surto costuma durar de poucos dias a semanas e periartrite ou tenossinovite também podem ocorrer.
Vírus da hepatite B	Causa de artrite **imunomediada por produção de imunocomplexos.** Os sintomas articulares ocorrem em 10-25% dos pacientes, cursando com **poliartralgia ou poliartrite, sendo aguda, simétrica, migratória ou aditiva de pequenas ou grandes articulações, tendo preferência por mãos e joelhos.** Esse quadro articular, em 50% dos pacientes, pode ser acompanhado de erupções urticariformes e maculopapulares que predominam em membros inferiores. Pode haver evolução para acometimento **articular crônico,** mas **é raro,** e também é descrita síndrome reumatoide *like* com fator reumatoide positivo.
Vírus da hepatite C	Também há produção de **imunocomplexos** que se depositam no tecido sinovial, mas ocorrem **poliartralgias e mialgias frequentemente. Oligo ou poliartrite não erosiva ocorre em 2-5%** dos pacientes, podendo ser do tipo reumatoide *like*, associada à crioglobulinemia (artrite, púrpura e crioglobulina no sangue) ou diretamente associada ao VHC. Os pacientes infectados pelo vírus C podem ter alguns **anticorpos positivos,** como fator reumatoide e anticorpos antinucleares.

HIV	Na **infecção aguda,** observa-se **artralgia transitória;** o fluido sinovial mostra padrão não inflamatório com predomínio de mononucleares. Artralgia, mialgia e artropatia soronegativa sem envolvimento axial são as manifestações mais associadas. **Artralgia** ocorre em 25-40% dos casos e é oligoarticular, intermitente, sendo mais de joelhos, de cotovelos e de ombros. **Mialgia** ocorre em 30% dos casos, sendo muito mais importante na fase aguda. Pode ser associada à terapia antirretroviral também. **Fibromialgia** pode ocorrer em 30%. A **artrite** propriamente dita, relacionada ao HIV, ocorre em 15% dos casos e tem o acometimento **agudo, assimétrico, não erosivo e não deformante.** O principal diagnóstico diferencial será a artrite reativa. A **forma reativa** ocorre em 20% dos casos, sendo **oligoarticular com predomínio para membros inferiores,** acompanhada de entesite e HLA B27 positivo em 80% dos pacientes. Por fim, **espondilite anquilosante** pode ocorrer em 2% dos casos.
Chikungunya	Na **fase aguda,** observamos poliartralgia/artrite e intensa mialgia. No geral, a **artrite** é mais de **membros inferiores, simétrica e bilateral. Rigidez articular,** principalmente em interfalangeanas, pés, tornozelos e punhos. A **mialgia** é mais frequente em braços, antebraços e coxas. Na **fase subaguda,** pode haver **exacerbação das dores articulares**, além de edema periarticular e sinovite. Doença que tem como principal característica o **risco de cronificação de artrite.** Os **fatores de risco clássicos para cronificação são:** sexo feminino, acima de 45 anos e com artropatia de base. **Na fase crônica,** é **bilateral e simétrica,** podendo ainda ser **migratória,** em 50% dos pacientes há rigidez matinal. **Edema de partes moles,** síndrome do túnel do carpo e fenômeno de Raynaud também podem ocorrer. Outras manifestações musculoesqueléticas são: tenossinovite, tendinite, entesite e bursite. 5% dos pacientes que evoluem para a forma crônica apresentarão quadro semelhante ao da artrite reumatoide, espondiloartrite ou poliartrite indiferenciada.

Artrites microcristalinas

↠ As artrites microcristalinas, também chamadas de doenças por deposição de cristais ou inflamação induzida por cristais, são consideradas as artrites inflamatórias mais comuns em diferentes partes do mundo. São caracterizadas, conjuntamente, pelas alterações articulares e periarticulares secundárias à resposta inflamatória aos microcristais formados e/ou depositados nos tecidos (CARVALHO et al., 2019).

Gota

↠ A gota é uma artropatia inflamatória causada pela deposição de cristais de monourato de sódio (MUS) nos tecidos articulares e extra- articulares (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Os 3 acometimentos principais da doença: articular, presença de tofos e acometimento renal (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Tem claro predomínio no sexo masculino, principalmente dos 30 aos 50 anos. Com o aumento da idade, cai a diferença entre homens e mulheres acometidos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OBS.: No sexo feminino, a maior incidência ocorre na faixa dos 55 e 70 anos devido à menopausa, uma vez que o estrógeno tem efeito uricosúrico, ou seja, aumenta a excreção na urina. Logo, diante de uma artropatia inflamatória em paciente idosa, a gota deverá ser uma hipótese diagnóstica (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Fatores de risco para hiperuricemia: ingesta excessiva de bebida alcoólica, carne e frutos do mar e medicamentos como diuréticos, baixas doses de AAS, ciclosporina, tacrolimo, etambutol, pirazinamida e ácido nicotínico (ESTRATÉGIAMED, 2024).
- Condições associadas: obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ETIOLOGIA

↠ A formação dos cristais decorre da supersaturação de urato nos tecidos envolvidos. Imagine o ácido úrico formando uma solução com os líquidos corporais. Ele será o soluto e os líquidos corporais, o solvente (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 04: Representação dos fatores que determinam o nível de urato no sangue. Adaptado de Xavier-Jr. Et. al., 2014

OBS.: O principal mecanismo envolvido na hiperuricemia é a hipoexcreção renal (ESTRATÉGIAMED, 2024).

QUADRO CLÍNICO

↠ A história natural da gota pode ser dividida, de forma didática, em quatro fases distintas: hiperuricemia assintomática, artrite gotosa aguda (crise aguda de gota), períodos intercríticos e gota crônica (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Apenas 10% dos pacientes com hiperuricemia desenvolverá a doença. Essa fase em que os níveis de ácido úrico se encontram acima de 7 mg/dL, mas que não há nenhum achado de gota, é denominada hiperuricemia assintomática.
- A doença gota geralmente ocorre após 10 a 30 anos de período assintomático, sendo manifestada como a primeira crise de gota.
- O período intercrítico é definido como o tempo livre de sintomas entre uma crise e outra. No início, as crises são bem esparsas, porém, com o passar do tempo (geralmente após 10 anos), tornam-se mais frequentes.
- A fase tofácea da doença é definida pela presença dos tofos, que são nódulos intra-articulares e subcutâneos resultantes do acúmulo de cristais nos tecidos. Ocorrem principalmente em cotovelo, tendão calcâneo, região dorsal de mãos e pés, joelhos, tornozelos e orelha externa. Geralmente, manifesta-se após 11 anos de doença e aqui as crises deixam de ser mono/oligoarticular e passam a apresentar caráter poliarticular.



↠ O pico de idade de início coincide com a quarta década de vida, sendo infrequente antes dos 30 anos. Os achados cardinais da crise são monoartrite com início súbito, associada aos comemorativos de inflamação, como dor, calor e rubor, que inclusive podem se estender além dos limites da articulação envolvida. A crise acontece mais comumente à noite ou nas primeiras horas da manhã (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ A articulação que é classicamente acometida é a metatarsofalangeana do hálux (85% a 90%), sendo também envolvidas as outras articulações dos demais pododáctilos, as tarsometatársicas, tornozelos, os joelhos, os punhos, as mãos e os cotovelos. Pode ocorrer, também, envolvimento de bursas e tendões (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ São fatores precipitantes de crise o abuso de álcool, cirurgias, traumas, sepse e medicamentos (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Existem três formas de acometimento renal: (ESTRATÉGIAMED, 2024).

- Nefropatia por uratos: aqui, o problema é a deposição crônica de urato no interstício renal, podendo levar à pielonefrite crônica e azotemia lentamente progressiva.
- Nefropatia aguda por ácido úrico: ocorre deposição de ácido úrico nos túbulos renais, sendo essa condição vista durante o tratamento quimioterápico de doenças neoplásicas nas quais há degradação excessiva de nucleoproteínas, hiperuricosúria e precipitação de ácido úrico nos ductos coletores. Apresenta a vantagem de ser facilmente prevenível com o uso de alopurinol, um inibidor de síntese de ácido úrico.
- Litíase renal por ácido úrico e/ou por associação deste com outros cristais (cálculos mistos): a forma mais comum de nefropatia relacionada à gota ocorre em cerca de 10% a 40% dos casos. Pacientes do sexo masculino que apresentam gota têm risco duas vezes maior de cálculos renais do que pacientes sem gota.

DIAGNÓSTICO

OBS.: O diagnóstico de gota apresenta alta probabilidade quando há alternância das crises agudas com períodos assintomáticos, principalmente em paciente com epidemiologia e condições clínicas compatíveis. Nos surtos da doença, o surgimento de dor forte, edema e eritema, que alcançam um pico entre 6h e 12h, são altamente sugestivos de inflamação por cristais, apesar de não específicos para gota (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Existem os critérios do ACR/EULAR de 2015 para definirmos o diagnóstico de gota, porém, na prática acabamos não usando muito (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Critério de entrada (obrigatório): ≥ 1 episódio de artrite/bursite			
	Manifestação	Discriminação	Pontos
Local	Crise (articulação/bursa)	Tornozelo ou médio pé	1
		1ª Metatarsofalângica	2
Artrite	Eritema	1 manifestação	1
	Muita sensibilidade ao toque	2 manifestações	2
	Limitação funcional	3 manifestações	3
Duração	Dor máxima em ≤ 24h Resolução ≤ 14 dias Resolução completa intercrítica (presença de 2 ou mais dos itens anteriores)	Um episódio	1
		Mais de um episódio	2
Tofo		Presente	4
Laboratório	Ácido úrico: • Após > 4 semanas da última crise • Valor historicamente mais alto	< 4 mg/dL	-2
		6 mg/dL a < 8 mg/dL	2
		8 mg/dL a < 10 mg/dL	3
		≥ 10 mg/dL	4
	Líquido sinovial (articulação/bursa)	Cristais de monourato ausentes	-2
Imagem	Ultrassonografia ou TC de dupla emissão	Evidência de deposição de urato	4
	Radiografia das mãos ou pés	Pelo menos uma erosão	4
GOTA se ≥ 8 pontos			
OU cristais presentes no líquido sinovial (critério suficiente)			

EXAMES COMLEMENTARES

↠ O diagnóstico de certeza da gota é dado pelo exame a fresco do líquido sinovial. Os achados de cristais em forma de agulha, típicos do urato monossódico, especialmente se fagocitados por leucócitos, são ditos patognomônicos da gota (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 12 — Representação do cristal de monourato de sódio em forma de agulha e de cor amarela quando paralelo à luz. Fonte: *Shutterstock*.

OBS.: A utilização de microscópio equipado com filtros polarizadores facilita a detecção dos cristais e sua diferenciação de outros materiais, por conta de sua forte birrefringência negativa. Os cristais apresentam cor amarela quando paralelos à luz. Essa mesma forma de diagnóstico pode ser realizada pelo exame do conteúdo dos tofos e bursas inflamadas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Cristal	Morfologia	Birrefringência	Luz paralela
Monourato de sódio	Agulha	Forte negativo	Amarela

TIPO DE LÍQUIDO	APARÊNCIA	CONTAGEM CELULAR/MM³	PORCENTAGEM DE POLIMORFONUCLEARES (%)
Normal	Claro, viscoso	0-200	< 10
Não inflamatório	Claro a discretamente turvo, com redução da viscosidade	200-2.000	< 20
Inflamatório *	Discretamente turvo, com redução da viscosidade	2.000-50.000	20-75
Gota pode variar a celularidade entre 20 mil e 100 mil			
Infeccioso (artrite séptica)	Turvo, purulento (em alguns casos)	> 50.000 a 100.000	> 75

↠ Quanto aos exames de imagem, o achado mais clássico ocorre na radiografia, como múltiplas erosões ósseas em saca-bocado assimétricas com bordas escleróticas e espiculadas (imagem em concha) (ESTRATÉGIAMED, 2024).



Figura 07: Representação da destruição articular típica da gota. Lesão em saca-bocado nas primeiras metatarsofalangeanas proximais. Observe as bordas escleróticas e apiculadas em formato de concha.

↠ Na ultrassonografia, podemos encontrar o "sinal do duplo contorno", que consiste em uma linha hiperecoica detectada na superfície da cartilagem. Apresenta boa especificidade para depósito de cristais, com até 95% de precisão (ESTRATÉGIAMED, 2024).

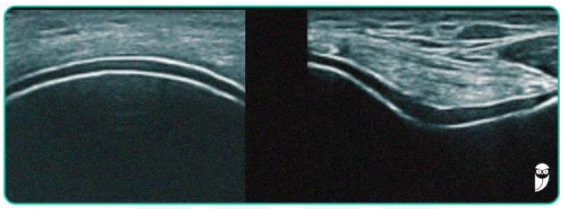


Figura 08: Ultrassom mostrando o sinal do duplo contorno na gota.

↠ Uma outra possibilidade é a tomografia computadorizada de dupla energia, na qual podemos detectar depósitos incipientes de cristais e até diferenciar os cristais de urato dos cristais de cálcio (ESTRATÉGIAMED, 2024).

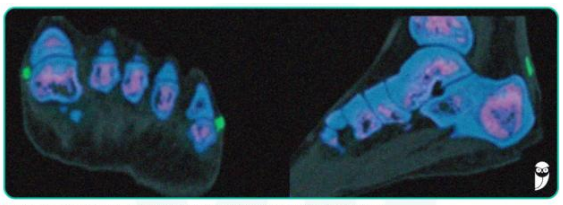


Figura 15 — Tomografia computadorizada de dupla energia mostrando áreas com sinais de ácido úrico (em verde).

TRATAMENTO

↠ Os objetivos do tratamento da gota são a recuperação da crise aguda, profilaxia de novas crises, redução da concentração de urato sérico, reabsorção dos tofos e prevenção da deposição de cristais (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Mudança de estilo de vida envolvendo perda de peso (se necessário), dieta pobre em purinas e redução do consumo de álcool são fundamentais (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Crise aguda

Quando estivermos diante de uma crise aguda de gota, o tratamento deve ser instituído o quanto antes, preferencialmente nas primeiras 24 horas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ Repouso relativo, com o objetivo de reduzir toda e qualquer sobrecarga que aumente a dor na região acometida, e compressas com gelo no local da inflamação podem ser úteis nos primeiros dias como medidas adjuvantes (ESTRATÉGIAMED, 2024).

ATENÇÃO: Caso o paciente já esteja em uso de medicação uricorredutora, ele não deve interrompê-la, já que rápidas flutuações no nível do ácido úrico, tanto para mais quanto para menos, podem piorar ou contribuir para manutenção da crise (ESTRATÉGIAMED, 2024).

↠ As drogas de primeira linha no tratamento da doença são os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), colchicina e glicocorticoides (oral, intramuscular ou intra-articular), isoladamente ou em combinações, não havendo hierarquia entre essas drogas (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OBS.: Na prática, não havendo contraindicação, um AINE em dose plena, associado ou não à colchicina em dose baixa (0,5 a 1 mg/dia), tem sido a opção mais empregada. A duração do tratamento é variável e, normalmente, é de 5 a 10 dias (ESTRATÉGIAMED, 2024).

A colchicina é classificada como um alcaloide modulador da formação e da função de microtúbulos celulares. Ela age inibindo a migração e a ativação de leucócitos e apresenta bons resultados, especialmente se usada nas primeiras 12 horas da crise aguda. A colchicina possui um efeito duplo no tratamento da gota, pois, além de tratar a crise, também atua na prevenção de novas crises (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Quanto aos glicocorticoides, a droga mais utilizada é a prednisona/prednisolona, por via oral, em doses de até 0,5 mg/ kg/dia no início com desmame progressivo. Metilprednisolona intravenosa ou betametasona/triancinolona injetáveis também podem ser utilizadas no manejo de pacientes internados que não possam receber medicação por via oral ou naqueles para os quais se deseje uma melhora rápida (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Injeção intra-articular de glicocorticoide é uma possibilidade, no entanto, esse é um procedimento bastante desconfortável em um paciente com crise aguda (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Manutenção

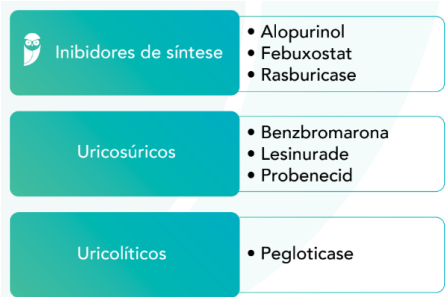
↠ A melhor forma de prevenir crises agudas é o controle da hiperuricemia a longo prazo (ESTRATÉGIAMED, 2024).

OBS.: O alvo terapêutico para a uricemia deve ser inferior a 6 mg/dL nos pacientes em geral. Naqueles com tofos, para que o processo de reabsorção ocorra de forma mais rápida, o alvo terapêutico é abaixo de 5 mg/dL (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Quando iniciar a terapia de manutenção? Após 2 a 3 semanas da crise totalmente resolvida, devemos partir para a terapia de fato uricorredutora (ESTRATÉGIAMED, 2024).

Indicação de terapia redutora de ácido úrico			
Ataques recorrentes de gota (2 ou mais episódios no ano)	Tofo detectado clinicamente	Lesão articular	Nefrolitíase

↠ Duas classes de drogas estão disponíveis para uso como agentes hipouricemiantes: os inibidores da xantina oxidase, que bloqueiam os passos metabólicos da síntese de ácido úrico, como o alopurinol, e os uricosúricos, que aumentam a excreção de ácido úrico, uma vez que bloqueiam sua reabsorção no rim mediada pela URAT 1. Já os uricolíticos promovem degradação direta do urato solúvel, mas não estão disponíveis no Brasil para uso (ESTRATÉGIAMED, 2024).



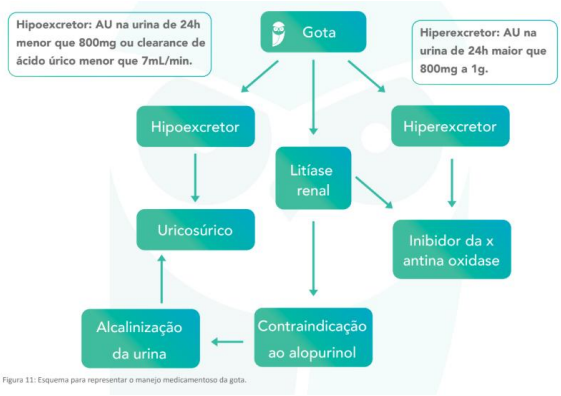


Figura 11: Esquema para representar o manejo medicamentoso da gota.

O alopurinol bloqueia a conversão de hipoxantina em xantina, impedindo a formação de ácido úrico por meio da inibição competitiva da xantina-oxidase (ESTRATÉGIAMED, 2024).

A benzbromarona é um uricosúrico bastante eficaz, sendo capaz de bloquear a reabsorção de ácido úrico mediada pela URAT1 (ESTRATÉGIAMED, 2024).

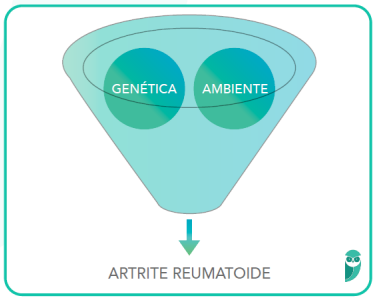
Artrite reumatoide

↠ A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune sistêmica de caráter inflamatório crônico que acomete, primariamente, a sinóvia, mas que também é associada a diversas manifestações extra-articulares (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ Apresenta clara predominância em mulheres, em uma proporção de 2 a 3 casos para cada homem acometido. A média de idade ao diagnóstico fica entre a 4ª e 6ª décadas de vida, com aumento de sua prevalência seguindo o aumento da idade (ESTRATÉGIAMED, 2023).

ETIOFISIOPATOLOGIA

↠ A base etiológica da AR envolve mecanismos autoimunes, ou seja, uma resposta imune disfuncional devido à presença de autoantígenos (ESTRATÉGIAMED, 2023).



↠ A predisposição genética, isoladamente, é responsável por apenas 10% a 20% da suscetibilidade à AR, com a maioria dos casos ocorrendo em famílias sem histórico da doença (ESTRATÉGIAMED, 2023).

O principal componente do risco genético está associado à presença de polimorfismos do gene HLA-DRB1, que codificam uma sequência de aminoácidos específica conhecida como "epítopo compartilhado". Em pacientes com essa sequência, o processo de apresentação de antígenos ao nosso sistema imune ocorre de forma aberrante, contribuindo para a hiperativação de linfócitos que será discutida mais à frente (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Com relação aos fatores ambientais, o tabagismo é o mais fortemente associado à AR. As substâncias presentes no cigarro induzem à produção de enzimas que modificarão peptídeos endógenos ("self"), tornando-os estranhos ao organismo e ativando resposta imunológica. No caso da AR, o processo mais importante que leva a essa modificação é a citrulinação (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ A ação de fatores ambientais sobre um indivíduo geneticamente predisposto resulta na quebra da barreira da autotolerância, ou seja, antígenos que antes eram "esquecidos" pelo sistema imune por serem reconhecidos como pertencentes àquele organismo ("self") sofrem modificações e passam a ser vistos como antígenos estranhos ("non-self"). Desse modo, tornam-se uma "ameaça" aos olhos do sistema imune, assim como uma bactéria ou vírus, e passam a ser combatidos como tal. E é durante esse combate que se desencadeia a cascata inflamatória responsável pelas manifestações clínicas da doença (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ Inicialmente, esses novos antígenos são apresentados aos linfócitos T, que, por sua vez, estimulam linfócitos B a

produzirem autoanticorpos, como o fator reumatoide (FR) e o anti-CCP (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ Acredita-se que a perpetuação dessa ativação imune aberrante gere um mecanismo de coestimulação, também conhecido como "segundo sinal", que faz com que os linfócitos T migrem em direção à membrana sinovial, o "revestimento" interno das articulações diartrodiais (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Os anticorpos e linfócitos T ativados exercem um papel patológico caracterizado pelo estímulo à proliferação das células que compõem a sinóvia e à produção de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF) e a interleucina 6 (IL-6), que, além de atuarem localmente, também atraem outras células para dentro da articulação, resultando na lesão-chave na AR: a sinovite (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ A interação entre as células e citocinas leva à formação de um tecido granulomatoso de caráter invasivo chamado pannus, que se expande além dos limites da sinóvia e infiltra estruturas adjacentes na articulação, causando um desarranjo anatômico marcado pelo comprometimento dos mecanismos de proteção e sustentação da articulação, dano à cartilagem e erosão óssea (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ Além disso, em meio a todo esse processo, ocorre estímulo à osteoclastogênese. Isso é importante porque, mais à frente, veremos que uma das manifestações radiográficas mais precoces vistas na AR é justamente a osteopenia periarticular e que a AR é fator de risco independente para o surgimento de osteoporose (ESTRATÉGIAMED, 2023).

MANIFESTAÇÕES ARTICULARES

↠ A AR apresenta início insidioso e, na maioria dos casos, acomete as articulações das mãos (metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais) e punhos. A sinovite manifesta-se com dor, edema, calor e, eventualmente, rubor sobre a articulação acometida e possui caráter aditivo, ou seja, as articulações somam-se até que surjam as clássicas poliartrites (> 4 articulações) crônica (> 6 semanas) e simétrica (afeta articulações em ambos os lados do corpo) (ESTRATÉGIAMED, 2023).

PADRÃO DE ACOMETIMENTO ARTICULAR NA ARTRITE REUMATOIDE

- **POLIARTICULAR**: mais de 4 articulações acometidas;
- **CRÔNICA**: sinovite presente há 6 semanas ou mais;
- **ADITIVA**: as articulações acometidas acumulam-se com o passar do tempo;
- **SIMÉTRICA**: acomete as mesmas articulações nos dois lados do corpo;
- **PEQUENAS E GRANDES ARTICULAÇÕES:** especialmente metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais, punhos e joelhos.

↠ A dor é dita inflamatória, porque piora com repouso e melhora com atividade e está associada à rigidez com duração, em geral, igual ou superior a 1 hora pela manhã (ESTRATÉGIAMED, 2023).

OBS.: De modo geral, as primeiras articulações acometidas na AR são as metacarpofalangeanas (MCF), interfalangeanas proximais (IFP) e punhos. Tanto que, inicialmente, a inflamação pode apenas ser notada através do "squeeze test", no qual comprimimos as metacarpofalangeanas e metatarsofalangeanas e o paciente refere dor (ESTRATÉGIAMED, 2023).



Figura 3: "Squeeze test".

↠ O desvio ulnar das MCFs, que decorre da subluxação dessas articulações (deslocamento da articulação que leva à perda parcial da sua congruência) e, associado ao desvio radial do punho, leva ao aspecto de "mão em Z" ou "dedos em ventania". O edema de punhos e MCFs associados à atrofia da musculatura interóssea fazem com que a mão de alguns pacientes se assemelhe a um dorso ou à "corcova" de um camelo (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ Com a progressão da AR, surgem suas deformidades típicas. Nas deformidades em pescoço de cisne e botoeira (ESTRATÉGIAMED, 2023).



Desvio ulnar dos dedos e subluxação de metacarpofalangeanas

Dedo em "pescoço de cisne": hiperextensão das interfalangeanas proximais e flexão das interfalangeanas distais.



Dedo em botoeira ou boutonnière: flexão das interfalangeanas proximais e hiperextensão das interfalangeanas distais.

Em decorrência do processo inflamatório em mãos e punhos, surgem também outras condições encontradas com muita frequência em pacientes com AR, como síndrome do túnel do carpo, "dedo em gatilho" (tenossinovite estenosante dos flexores) e roturas tendíneas (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Os joelhos são acometidos na maioria dos pacientes e o derrame articular, quando presente, pode ser identificado pela perda dos sulcos, aumento de volume da articulação e pelo "sinal da tecla", caracterizado pelo movimento de "desce e sobe" da patela após a mobilização do

líquido sinovial no joelho e compressões ativas realizadas pelo examinador (ESTRATÉGIAMED, 2023).

O acometimento da coluna vertebral pela AR resume-se, basicamente, à região cervical, especialmente em pacientes com anticorpos positivos e doença de longa data. A maioria dos pacientes é assintomática e os primeiros sinais de alerta para esse acometimento são cefaleia occipital e cervicalgia. Com a progressão da doença, o processo inflamatório gera erosões ósseas e frouxidão ligamentar, fatores diretamente envolvidos no surgimento de uma das mais temidas complicações da AR: a subluxação atlantoaxial (articulação entre C1-C2) (ESTRATÉGIAMED, 2023).

MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES

↠ Por tratar-se de uma doença de caráter inflamatório sistêmico, é comum que no início do quadro tenhamos queixas, como fadiga, mal-estar e perda de peso, mas os destaques aqui são as manifestações decorrentes do acometimento de diversos órgãos e sistemas (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Tabela 1: principais manifestações extra-articulares da artrite reumatoide.

Cutâneas	Nódulos reumatoides, pioderma gangrenoso.
Oftalmológicas	Ceratoconjuntivite seca, episclerite, esclerite.
Pulmonares	Pleurite, doença intersticial pulmonar.
Cardiovasculares	Pericardite, aumento de risco cardiovascular.
Vasculíticas	Hemorragias periungueais, infarto e gangrena.
Neurológicas	Mielopatia cervical associada à subluxação atlanto-axial, síndrome do túnel do carpo, mononeurite múltipla.
Hematológicas	Síndrome de Felty (artrite reumatoide, esplenomegalia e neutropenia).
Renais (incomum)	Amiloidose AA ou secundária.
Osteometabólicas	Osteoporose (artrite reumatoide como fator de risco independente e uso de glicocorticoides)

Os nódulos reumatoides são as manifestações extra-articulares mais descritas nas questões. Surgem mais frequentemente em superfícies extensoras (ex., antebraço), são fibroelásticos, na maioria dos casos indolores e estão fortemente associados ao fator reumatoide e pior prognóstico (ESTRATÉGIAMED, 2023).



EXAMES COMPLEMENTARES

↠ Por tratar-se de uma doença inflamatória sistêmica, anemia de doença crônica e plaquetose podem ser encontradas em pacientes em atividade (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ Provas de atividade inflamatória, como proteína C-reativa (PCR) e velocidade de hemossedimentação (VHS), encontram-se aumentadas na maioria dos pacientes em atividade de doença, por isso são importantes tanto para diagnóstico quanto para seguimento (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ O FAN é positivo em 30% a 50% dos pacientes, mas, diferentemente de outras doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, não reflete a presença de autoanticorpos específicos (ESTRATÉGIAMED, 2023).

OBS.: Em casos duvidosos quanto ao diagnóstico ou coexistência de outras condições (p.ex., gota e artrite infecciosa), devemos realizar artrocentese e encaminhar o líquido sinovial para análise. O líquido típico da AR tem caráter inflamatório e celularidade entre 2.000/mm³ a 50.000/mm³ com 20% a 75% de polimorfonucleares (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ O FR está presente em 70% a 80% dos casos, mas, assim como sua ausência não descarta o diagnóstico, sua presença também não o confirma, já que ele pode ser positivo em diversas outras situações, como infecções crônicas, neoplasias e até mesmo em pacientes, especialmente idosos (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Fator reumatoide e anti-CCP apresentam sensibilidade semelhante, mas o anti-CCP é mais específico para o diagnóstico de artrite reumatoide.

↠ Quanto aos achados de imagem, o método de avaliação de escolha é a radiografia convencional (ESTRATÉGIAMED, 2023).

↠ Inicialmente, esperamos encontrar apenas edema de partes moles pelo quadro inflamatório e osteopenia periarticular pela ação de citocinas e ativação de osteoclastos. Com a evolução do quadro, surgem as clássicas erosões ósseas marginais, redução simétrica do espaço articular por comprometimento da cartilagem e, em casos avançados, a perda completa desse espaço com fusão óssea (anquilose), especialmente no carpo (ESTRATÉGIAMED, 2023).

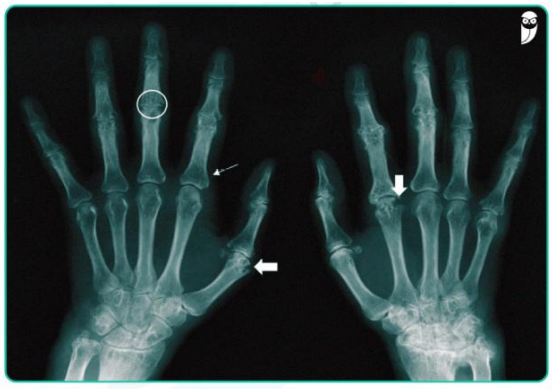


Figura 15: radiografia de mãos e punhos mostrando osteopenia periarticular (seta fina), redução simétrica do espaço articular (círculo) e erosões ósseas marginais (setas grossas). Note também o importante comprometimento do punho, da articulação radiocarpal e da ulna à esquerda.

Júlia Morbeck – @med.morbeck

OBS.: A ressonância magnética é o método mais sensível para diagnosticar as alterações inflamatórias associadas à AR, principalmente em casos iniciais ou duvidosos. No entanto, seu alto custo e menor disponibilidade dificultam seu uso na prática clínica (ESTRATÉGIAMED, 2023).

DIAGNÓSTICO

→ O diagnóstico da AR é clínico e deve envolver anamnese e exame físico sugestivos, com solicitação de exames complementares para auxiliar em casos duvidosos, definir prognóstico e avaliar diagnósticos diferenciais (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Tabela 3 : critérios classificatórios para artrite reumatoide segundo o ACR/EULAR (2010).	
Acometimento articular (0-5)	Pontuação
1 grande articulação	0
2 a 10 grandes articulações	1
1 a 3 pequenas articulações (não conta grandes)	2
4 a 10 pequenas articulações (não conta grandes)	3
> 10 articulações (pelo menos 1 pequena)	5
Sorologia (0-3)	
FR negativo e anti-CCP negativo	0
FR positivo ou anti-CCP positivo em baixos títulos (< 3 vezes o limite superior da normalidade)	2
FR positivo ou anti-CCP positivo em altos títulos (> 3 vezes o limite superior da normalidade)	3
Duração dos sintomas (0-1)	
< 6 semanas	0
≥ 6 semanas	1
Provas de atividade inflamatória (0 a 1)	
PCR e VHS normais	0
PCR ou VHS anormais	1

*Para classificarmos o paciente com artrite reumatoide devemos obter uma pontuação ≥ 6.

OBS.: Note que as maiores pontuações são atribuídas aos itens mais característicos da AR, como poliartrite de pequenas articulações há mais de 6 semanas em paciente com anticorpos positivos em altos títulos e provas de atividade inflamatória elevada. Além disso, perceba que não há menção a achados radiográficos nos critérios de 2010 (ESTRATÉGIAMED, 2023).

TRATAMENTO

→ O principal objetivo do tratamento da AR é controlar a atividade de doença visando melhora sintomática, prevenção de sequelas, redução de risco cardiovascular e melhora da qualidade de vida dos pacientes (ESTRATÉGIAMED, 2023).

O DAS28 (**Disease Activity Score**), que avalia 28 articulações utiliza dados clínicos, laboratoriais e avaliação subjetiva do paciente quanto a sua saúde para calcular um valor numérico que expressa o nível de atividade da doença. Como o DAS28 envolve um algoritmo específico, você deve utilizar calculadoras on-line ou aplicativos para calculá-lo (ESTRATÉGIAMED, 2023).

- Número de articulações dolorosas (0 a 28);
- Número de articulações edemaciadas (0 a 28);
- Valor do PCR ou VHS (para cada um deles há uma fórmula diferente);
- Nota do paciente baseada no VAS (escala visual analógica) para avaliação global da saúde (0-10 mm).

Tabela 5: resposta DAS28 na artrite reumatoide.	
Remissão	≤ 2,6
Baixa atividade	2,7 a 3,2
Moderada atividade	3,3 a 5,1
Alta atividade	>5,1



Figura 16: DAS28

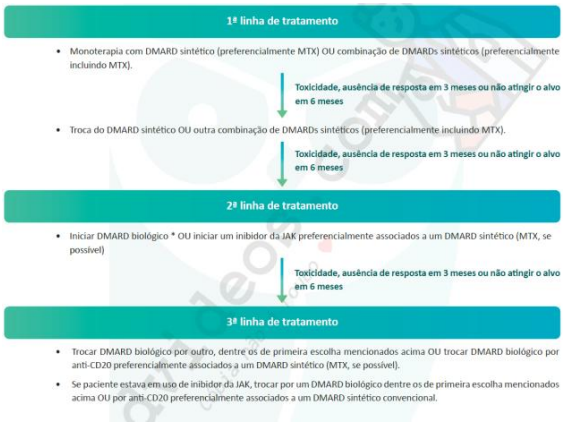
→ O tratamento da AR envolve medidas não farmacológicas, como cessação do tabagismo e controle de fatores de risco cardiovascular "extras" (ex., hipertensão, diabetes, dislipidemia) (ESTRATÉGIAMED, 2023).

→ Feito o diagnóstico de AR, devemos iniciar medicações pertencentes a dois grupos: sintomáticas e drogas antirreumáticas modificadoras do curso da doença (DMARDs)

Dentre as de ação sintomática, encontramos os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e os glicocorticoides, especialmente a prednisona em doses baixas a moderadas (até 15 mg/dia), excelentes para o controle rápido da inflamação, mas que não modificam a história natural da AR. (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Já os DMARDs são caracterizados justamente pelo início de ação mais lento, mas com poder de evitar ou retardar o surgimento da erosão óssea e, consequentemente, de deformidades e limitação funcional (ESTRATÉGIAMED, 2023).

SINTÉTICOS CONVENCIONAIS	BIOLÓGICOS
Metotrexato	Anti-TNF (Infliximabe, adalimumabe, etanercept, golimumabe, certolizumabe)
Leflunomida	Antirreceptor da interleucina-6 (tocilizumabe)
Sulfassalazina	Modulador da coestimulação de linfócitos T (abatacept)
Antimaláricos (hidroxicloroquina, cloroquina)	Anti-CD20 (rituximabe)
* Inibidores da JAK (tofacitinibe) são considerados pequenas moléculas sintéticas alvo-específicos, mas para fins de indicação no tratamento da AR e seguimento dos pacientes, devem ser encarados como um imunobiológico.	



Metotrexato deve ser prescrito, inicialmente, em doses de 7,5 mg a 12,5 mg por semana até a dose máxima de 25 mg por semana. Como o MTX age competindo com a enzima diidrofolato redutase, na falta do ácido fólico, os pacientes apresentarão eventos adversos, como citopenias isoladas (especialmente anemia megaloblástica) ou mesmo pancitopenia. Em geral, prescrevemos a dose de 5 mg por semana (ESTRATÉGIAMED, 2023).

ATENÇÃO: Metotrexato é a droga de escolha no tratamento da artrite reumatoide e deve ser prescrito em doses semanais associado ao ácido fólico/folínico (ESTRATÉGIAMED, 2023).

ATENÇÃO: Antes de trocar um DMARD por considerá-lo ineficaz, você deve utilizar essa droga em sua dose máxima preconizada (ESTRATÉGIAMED, 2023).

Tabela 7: classificação da resposta terapêutica na artrite reumatoide segundo o EULAR-DAS28.	
Boa resposta	Queda > 1,2 no DAS, atingindo DAS28 ≤ 3,2.
Moderada resposta	Queda > 1,2 mantendo DAS28 > 3,2 ou queda entre > 0,6 e ≤ 1,2 atingindo DAS28 < 5,1.
Ausência de resposta	Queda > 0,6 e ≤ 1,2, mantendo DAS28 > 5,1 ou queda ≤ 0,6.

Impacto da automedicação

↠ A automedicação pode ser definida como o uso de produtos sem recomendação ou supervisão médica, sendo caracterizada pela iniciativa próprio do doente em consumir drogas farmacêuticas, objetivando tratar ou aliviar sintomas ou doenças na promoção pela saúde (DE MORAIS; JÚNIOR FURLAN).

Dentre as práticas da automedicação estão a aquisição de medicamentos sem receita, o compartilhamento de medicamentos com outros membros da família ou círculo social, reutilização de sobras de medicamentos de tratamentos anteriores, utilização de antigas prescrições e prolongamento de um tratamento indicado pelo médico (DE MORAIS; JÚNIOR FURLAN).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o percentual de internações hospitalares advindas de reações adversas a drogas farmacêuticas ultrapassa 10%, pois 50% dos medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos, sendo que metade dos pacientes faz uso incorreto (DE MORAIS; JÚNIOR FURLAN).



Figura 1. Os remédios mais consumidos na automedicação de adultos no Brasil.

Os analgésicos que são os fármacos mais usados na automedicação ocupam destaque também entre os idosos, sendo mais utilizados para tratamento de dor e inflamação, sintomas bastante comuns nessa fase (DE MORAIS; JÚNIOR FURLAN).

Referências

JAMESON, J L.; FAUCI, Anthony S.; KASPER, Dennis L.; et al. Manual de medicina de Harrison. 20. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2021.

REZENDE, M. U.; CAMPOS, G. C. A osteoartrite é uma doença mecânica ou inflamatória? Revista Brasileira de Ortopedia, 2013.

KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; ASTER, Jon C. Robbins & Cotran Patologia: Bases Patológicas das Doenças. Grupo GEN, 2023.

CARVALHO, Marco Antonio P.; LANNA, Cristina Costa D.; BERTOLO, Manoel B. Reumatologia - Diagnósttico e Tratamento, 5ª edição. Grupo GEN, 2019.

DE MORAIS E..; JÚNIOR FURLAN O. Consequências e quais os principais riscos da automedicação. Disponível em: https://www.unifacvest.edu.br/assets/uploads/files/arquivos/e692c-ereni-de-morais---consequencias-e-quais-os-principais-riscos-da-automedicacao.pdf

ESTRATÉGIAMED, 2024.

ESTRATÉGIAMED, 2023.